

急诊与灾难医学 batch035 题库 (220题) 题库 (220题)

来源：最终产物\batch035\ALL_questions_FIXED.json | 导出：2026-09-07 10:09

题型分布：A1×100、A2×46、X×30、A3×24、B1×20

Bloom分布：记忆×77、理解×70、应用×64、分析×9

M1 (8题)

1. [A1型题 | 理解] batch035-M1-A1-001

模块：M1 | 页码：教材P1

急诊医学的核心内涵是

- A. 院前急救、院内急诊和危重症监护一体化模式
- **B. 早期判断,迅速救治,保护脏器功能生命安全** ✓
- C. 急救人员、车辆、通信的调动准备和现场急救
- D. 对灾难的预见、预防和准备及灾后卫生防疫
- E. 对慢性疾病进行长期随访和康复治疗

答案：B

解析：急诊医学是对急危重症、创伤和意外伤害进行评估、急诊处理、治疗和预防的学科专业，其核心是早期判断、迅速有效救治、保护脏器功能和生命安全。教材P1。

2. [A1型题 | 记忆] batch035-M1-A1-002

模块：M1 | 页码：教材P2

急诊分诊中，II类病人应在多长时间内进行病情评估和治疗

- A. 立即进行抢救
- **B. 10分钟内** ✓
- C. 30分钟内
- D. 1小时内
- E. 2小时内

答案：B

解析：急诊分诊将病人分为5类：I类生命垂危需立即抢救；II类随时危及生命应在10分钟内评估治疗；III类存在危及生命状况应在30分钟内评估；IV类潜在危重可在1小时内处理；

V类非紧急可适当延时，一般2小时内处理。教材P2。

3. [A1型题 | 理解] batch035-M1-A1-003

模块：M1 | 页码：教材P1

关于院前急救技术指标，急救反应时间是指

- A. 从接到求救电话到派出救护车抵达现场的时间 ☒
- B. 急救人员在现场对伤病员救治的时间
- C. 从现场到医院的转运时间
- D. 从发病到开始实施急救的时间
- E. 从入院到开始确定性治疗的时间

答案：A

解析：急救反应时间是从接到求救电话到派出救护车抵达伤病现场的平均时间，国际目标要求为5~10分钟。现场抢救时间是急救人员在现场对伤病员救治的时间，转运时间是从现场到医院的时间。教材P1。

4. [A1型题 | 理解] batch035-M1-A1-004

模块：M1 | 页码：教材P3-4

关于急诊医学专业特点的描述，错误的是

- A. 急症病情危重、进展难预料，具危重复杂性
- B. 救治时间窗内早期目标治疗，具时限急迫性
- C. 早期纠正器官功能紊乱可逆转，具机制可逆性
- D. 急诊症状零乱复杂，需跨专科综合分析
- E. 急诊应优先明确诊断再抢救，处置强调先诊断 ☒

答案：E

解析：急诊医学强调“救人治病”的原则，即将抢救生命作为第一目标，而非先明确诊断再抢救。急诊专业特点包括危重复杂性、时限急迫性、机制可逆性、综合关联性和处置简捷性。教材P3-4。

5. [A1型题 | 记忆] batch035-M1-A1-005

模块：M1 | 页码：教材P5

急诊处理临床问题的思维方法中，首要的评估步骤是

- A. 询问详细发病经过和既往病史
- B. 进行全面的体格检查
- C. 评价病人气道、呼吸和循环 ✓
- D. 立即安排实验室和影像学检查
- E. 根据临床表现做出确定性诊断

答案：C

解析：急诊处理临床问题的思维方法归纳为：①评价病人“A-B-C”(气道、呼吸、循环)，判断有无生命危险，如有危险要立即抢救；②无论是否能立即做出临床诊断，都要马上评估病情严重程度；③根据病情采取相应救治措施；④继续观察病情变化，重复评估。教材P5。

6. [A2型题 | 应用] batch035-M1-A2-001

模块：M1 | 页码：教材P2

男性,68岁。突发胸痛2小时,伴大汗、呼吸困难,血压85/50mmHg,心电图示急性广泛前壁心肌梗死。根据急诊分诊标准,该病人应属于

- A. I类——生命垂危病人 ✓
- B. II类——随时危及生命的病人
- C. III类——存在危及生命状况的病人
- D. IV类——潜在危重状况的病人
- E. V类——非紧急的病人

答案：A

解析：患者急性广泛前壁心肌梗死，血压85/50mmHg提示心源性休克，生命垂危，属于I类病人，需要立即进行抢救。I类为生命垂危病人，需立即抢救；II类为随时危及生命病人，应在10分钟内评估治疗。教材P2。

7. [B1型题 | 理解] batch035-M1-B1-001

模块：M1 | 页码：教材P3

急诊医学强调的基本原则是

- A. 先抢后救，先使伤员脱离危险环境
- B. 救人治病，将抢救生命作为第一目标 ✓

- C. 先明确诊断，再针对病因进行治疗
- D. 先完善检查，再决定治疗方案
- E. 先转运后抢救，尽快送达医院

答案：B

解析：急诊医学强调“救人治病”的原则，即将抢救生命作为第一目标。只有在生命体征稳定的情况下，才能赢得确定诊断和针对病因治疗的时机。灾难医学的原则是“先抢后救”，强调先使伤员脱离危险环境再进行分拣急救。教材P3。

8. [X型题 | 理解] batch035-M1-X-001

模块：M1 | 页码：教材P1-2

我国急救医疗服务体系（EMSS）的组成部分包括

- A. 院前急救 ☒
- B. 医院急诊 ☒
- C. 危重症监护 ☒
- D. 社区卫生服务中心
- E. 康复医疗机构

答案：ABC

解析：我国目前的急救医疗服务体系（EMSS）是院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体的模式。院前急救是指到达医院前对急症、创伤病人开展现场或转运途中的医疗救治；医院急诊是EMSS中最重要而又最复杂的中心环节；危重症监护是指在急诊抢救和观察区域内实现完备的监护和抢救的医疗功能。教材P1-2。

M2（30题）

9. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-001

模块：M2 | 页码：教材P157

关于急性中毒的临床特点，下列哪项不正确****

- A. 起病急骤，症状严重
- B. 病情变化迅速，常危及生命
- C. 病程较长且缺乏特异性诊断指标 ☒
- D. 短时间内吸收大量毒物所致
- E. 需及时治疗以防生命危险

答案：C

解析：急性中毒是指短时间内吸收大量毒物导致躯体损害，起病急骤，症状严重，病情变化迅速，如不及时治疗常危及生命。慢性中毒是长时间吸收少量毒物的结果，起病缓慢，病程较长，缺乏特异性诊断指标，多不属于急诊范畴。教材P157。

10. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-002

模块：M2 | 页码：教材P157

毒物吸收后主要在哪里代谢，其代谢产物主要经何种途径排出

- A. 肾脏代谢，肝脏排出
- B. 肺脏代谢，消化道排出
- C. 脾脏代谢，呼吸道排出
- D. 肝脏代谢，肾脏排出 ✓
- E. 脑组织代谢，皮肤排出

答案：D

解析：毒物吸收后经血液分布于全身，主要在肝脏代谢。多数毒物代谢后毒性降低（解毒），但也有少数毒物代谢后毒性反而增强，如对硫磷氧化为毒性更强的对氧磷。体内毒物主要由肾脏排出，气体和易挥发毒物还可以原型经呼吸道排出。教材P157。

11. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-003

模块：M2 | 页码：教材P157

一氧化碳、硫化氢、氰化物等窒息性毒物导致机体中毒的主要机制是

- A. 局部腐蚀和刺激作用
- B. 麻醉作用抑制脑功能
- C. 阻碍氧的吸收、转运或利用 ✓
- D. 抑制酶的活力
- E. 干扰细胞器的生理功能

答案：C

解析：一氧化碳、硫化氢、氰化物等窒息性毒物可阻碍氧的吸收、转运或利用，使机体组织和器官缺氧。抑制酶的活力是有机磷等毒物的机制，麻醉作用是有机溶剂和吸入性麻醉药的机制。教材P157。[源:考研真题 GS-2003-025]

12. [A1型题 | 记忆] batch035-M2-A1-004

模块：M2 | 页码：教材P162

急性有机磷杀虫剂中毒时，下列属于毒蕈碱样（M样）症状的是

- A. 颜面肌纤维颤动
- B. 呼吸肌麻痹
- C. 瞳孔缩小、多汗、流涎 ☒
- D. 四肢强直性痉挛
- E. 肌力减退和瘫痪

答案：C

解析：毒蕈碱样症状（M样症状）在三种表现中出现最早，主要由于副交感神经末梢兴奋，平滑肌痉挛和腺体分泌增加，表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、多汗、流涎、瞳孔缩小、气道分泌物增加、支气管痉挛等。A、B、D、E均为烟碱样（N样）症状。教材P162。[源：考研真题 GS-2018-156]

13. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-005

模块：M2 | 页码：教材P163

急性有机磷杀虫剂中毒中度中毒时，全血胆碱酯酶活力为

- A. 70%以上
- B. 50%~70%
- C. 30%~50% ☒
- D. 15%~30%
- E. 15%以下

答案：C

解析：急性有机磷中毒程度分级：轻度中毒以M样症状为主，胆碱酯酶活力为50%~70%；中度中毒M样症状加重并出现N样症状，胆碱酯酶活力为30%~50%；重度中毒合并肺水肿、呼吸衰竭、抽搐、昏迷等，胆碱酯酶活力在30%以下。教材P163。[源：考研真题 GS-2012-067]

14. [A1型题 | 记忆] batch035-M2-A1-006

模块：M2 | 页码：教材P164

目前推荐用于急性有机磷杀虫剂中毒急救的首选抗胆碱药是

- A. 阿托品
- **B. 盐酸戊乙奎醚** ✓
- C. 碘解磷定
- D. 氯解磷定
- E. 双复磷

答案：B

解析：目前推荐用盐酸戊乙奎醚替代阿托品作为有机磷杀虫剂中毒急救的首选抗胆碱药，因其具有拮抗腺体分泌效应更强、有较强拮抗N受体作用、中枢和外周双重抗胆碱效应、不引起心动过速、半衰期长、中毒发生率低等优点。教材P164。

15. [A1型题 | 记忆] batch035-M2-A1-007

模块：M2 | 页码：教材P164

下列哪项不是有机磷中毒阿托品化的判定标准

- A. 瞳孔较前扩大
- B. 皮肤干燥、颜面潮红
- C. 心率较前增快
- D. 肺部啰音消失
- **E. 瞳孔明显扩大伴意识模糊** ✓

答案：E

解析：阿托品化指征为瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、颜面潮红、心率增快、肺部湿啰音消失。E选项瞳孔明显扩大伴意识模糊提示阿托品中毒，而非阿托品化。阿托品中毒时应立即停用阿托品，酌情给予毛果芸香碱对抗。教材P164。[源:考研真题 GS-2007-143]

16. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-008

模块：M2 | 页码：教材P166

百草枯中毒最突出和最严重的损害器官是

- A. 肝脏
- B. 肾脏
- **C. 肺脏** ✓
- D. 心脏
- E. 中枢神经

答案：C

解析：百草枯中毒时肺损伤是最突出和最严重的改变。百草枯在肺组织含量为血液中的10倍或数十倍，通过过氧化损伤和炎症等机制导致肺损伤。大剂量服毒者可在24~48小时出现进行性呼吸困难，呼吸衰竭是病人死亡的主要原因。教材P166。

17. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-009

模块：M2 | 页码：教材P176

关于急性一氧化碳中毒的治疗，下列哪项是正确的

- A. 面罩吸氧是治疗最有效的方法
- **B. 高压氧治疗可缩短昏迷时间和病程** ✓
- C. 高压氧治疗仅适用于重度中毒患者
- D. COHb浓度降至15%即可停止吸氧
- E. 机械通气不适用于CO中毒的治疗

答案：B

解析：氧疗是治疗一氧化碳中毒最有效的方法，高压氧治疗能增加血液中物理溶解氧含量，COHb解离速度较正常吸氧时快4~5倍，可缩短昏迷时间和病程，预防迟发性脑病发生。高压氧适用于中、重度中毒，或出现神经精神症状、COHb浓度≥25%者。教材P176。

18. [A1型题 | 记忆] batch035-M2-A1-010

模块：M2 | 页码：教材P161

苯二氮䓬类中毒的特效解毒药是

- A. 纳洛酮
- **B. 氟马西尼** ✓
- C. 烯丙吗啡
- D. 亚甲蓝
- E. 乙酰胺

答案：B

解析：氟马西尼是苯二氮䓬类中毒的特效解毒药，能竞争性抑制苯二氮䓬受体，阻断该类药物对中枢神经系统的作用。用法：0.2mg静脉注射，酌情重复，总量可达2mg。纳洛酮用于阿片类和酒精中毒；亚甲蓝用于高铁血红蛋白血症；乙酰胺用于氟乙酰胺中毒。教材P161、P172。[源:考研真题 GS-2021-130]

19. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-011

模块：M2 | 页码：教材P160-161

对于脂溶性强、蛋白结合率高、分子量大的毒物中毒，首选的血液净化方式是

- A. 血液透析
- **B. 血液灌流** ✓
- C. 血浆置换
- D. CRRT
- E. 腹膜透析

答案：B

解析：血液灌流对分子量500~40000Da的水溶性和脂溶性毒物均有清除作用，因其对脂溶性强、蛋白结合率高、分子量大的毒物的清除能力远大于血液透析，故常作为急性中毒的首选净化方式。血液透析可清除分子量小于500Da、水溶性强、蛋白结合率低的毒物。教材P160-161。

20. [A1型题 | 理解] batch035-M2-A1-012

模块：M2 | 页码：教材P168

毒鼠强中毒时控制惊厥应首选的药物是

- A. 乙酰胺
- B. 维生素K1
- **C. 地西泮** ✓
- D. 亚甲蓝
- E. 纳洛酮

答案：C

解析：毒鼠强可拮抗γ-氨基丁酸（GABA）受体，导致中枢神经系统过度兴奋而引起惊厥。抗惊厥治疗选用地西泮、苯巴比妥钠、羟丁酸钠、二巯丙磺钠等药物。乙酰胺为氟乙酰胺的特效解毒药；维生素K1为抗凝血类杀鼠剂的特效药。教材P168。

21. [A1型题 | 记忆] batch035-M2-A1-013

模块：M2 | 页码：教材P173

急性酒精中毒昏迷期，血乙醇浓度通常超过

- A. 500mg/L
- B. 1000mg/L
- C. 1500mg/L
- D. 2000mg/L
- E. 2500mg/L ☒

答案：E

解析：血乙醇浓度大于500~1500mg/L为兴奋期；大于1500~2500mg/L为共济失调期；大于2500mg/L为昏迷期，病人进入昏迷状态，瞳孔散大，体温不升，血压下降，呼吸减慢，严重者可发生呼吸、循环衰竭。教材P173。

22. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-001

模块：M2 | 页码：教材P163

女性,20岁。误服有机磷农药后半小时家人送来急诊。查体:神志不清,皮肤潮湿多汗,面部肌肉束颤动,瞳孔缩小,双肺布满湿啰音。该患者最可能的中毒程度是

- A. 轻度中毒
- B. 中度中毒
- C. 重度中毒 ☒
- D. 不能确定
- E. 隐匿性中毒

答案：C

解析：患者神志不清，应诊断为重度有机磷中毒。皮肤潮湿多汗、瞳孔缩小、双肺湿啰音为M样症状，面部肌肉束颤动为N样症状。重度中毒指M样和N样症状外，还合并脑水肿、肺水肿、呼吸衰竭、抽搐、昏迷等，胆碱酯酶活力在30%以下。教材P163。[源:考研真题GS-2015-068]

23. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-002

模块：M2 | 页码：教材P175-176

男性,45岁。冬季室内使用煤炉取暖,晨起被家人发现昏迷。查体:昏迷状态,口唇呈樱桃红色,呼吸浅慢,心率110次/分,血压90/60mmHg。为明确诊断，应首选的检查是

- A. 动脉血气分析

- B. 血碳氧血红蛋白测定 ☒
- C. 颅脑CT检查
- D. 常规心电图
- E. 血电解质测定

答案：B

解析：患者有明确的室内煤炉取暖史，晨起昏迷，口唇樱桃红色，高度提示急性一氧化碳中毒。血碳氧血红蛋白浓度增高是一氧化碳中毒的特异性诊断指标，该检查有助于确诊和判断中毒程度。教材P175-176。

24. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-003

模块：M2 | 页码：教材P167

男性,28岁。口服百草枯约30ml后2小时来诊。查体:神志清楚,口腔黏膜糜烂,双肺呼吸音清。应立即采取的措施中,最重要的是

- A. 尽早进行血液灌流治疗 ☒
- B. 大剂量甲泼尼龙冲击治疗
- C. 高浓度吸氧改善缺氧
- D. 立即使用环磷酰胺
- E. 静脉输注碳酸氢钠碱化尿液

答案：A

解析：百草枯中毒目前尚无特效治疗，尽早排出毒物、血液净化等早期综合救治是关键。洗胃完成后应及早进行血液灌流治疗，有肾损害者可行血液灌流联合血液透析。高浓度氧气吸入可加重肺组织损害，仅在 $\text{PaO}_2 < 40\text{mmHg}$ 时才能使用。教材P167。

25. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-004

模块：M2 | 页码：教材P163

男性,35岁。自服敌百虫约50ml后1小时来急诊。查体:神志模糊,瞳孔针尖样缩小,大汗淋漓,肌纤维颤动。洗胃时禁用的洗胃液是

- A. 清水洗胃液
- B. 2%碳酸氢钠溶液 ☒
- C. 高锰酸钾洗胃液
- D. 生理盐水洗胃液
- E. 温开水洗胃液

答案：B

解析：口服中毒者可用清水、2%碳酸氢钠或1:5000高锰酸钾溶液洗胃。但敌百虫中毒时禁用碳酸氢钠洗胃，因为碳酸氢钠可将敌百虫转化为敌敌畏，使毒性显著增强；对硫磷中毒时禁用高锰酸钾洗胃，因为高锰酸钾可将对硫磷氧化为对氧磷，使毒性增强。教材P163。
[源:考研真题 GS-2023-156]

26. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-005

模块：M2 | 页码：教材P161

男性,25岁。被发现昏迷,身边有注射器。查体:昏迷,瞳孔针尖样缩小,呼吸浅慢(6次/分),口唇发绀。应首先采取的治疗措施是

- A. 静脉注射纳洛酮 ☒
- B. 静脉注射氟马西尼
- C. 血液灌流治疗
- D. 静脉注射亚甲蓝
- E. 静脉注射乙酰胺

答案：A

解析：患者有注射史、昏迷、瞳孔针尖样缩小、呼吸抑制，符合吗啡或海洛因中毒的典型三联征。纳洛酮为阿片受体拮抗剂，对麻醉性镇痛药所致的呼吸抑制有特异性拮抗作用，用法：0.4~0.8mg静脉注射，酌情重复，总量可达10~20mg。教材P161。

27. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-006

模块：M2 | 页码：教材P169

一家三口进食自制罐头后出现头晕、乏力,继而出现眼睑下垂、吞咽困难、言语含糊。查体:神志清楚,双侧瞳孔等大等圆,对光反射存在,肌力正常。最可能的诊断和治疗措施是

- A. 河鲀毒素中毒，尽早使用阿托品
- B. 肉毒杆菌中毒，尽早使用肉毒抗毒血清 ☒
- C. 有机磷中毒，尽早使用阿托品和氯解磷定
- D. 毒蕈中毒，尽早使用阿托品
- E. 亚硝酸盐中毒，尽早使用亚甲蓝

答案：B

解析：肉毒杆菌中毒常见于进食罐头食品，以中枢神经系统症状为主，表现为眼肌麻痹、吞咽困难、言语困难、呼吸肌麻痹等。肉毒抗毒血清是特效治疗，发病24小时内最有效。

28. [A2型题 | 应用] batch035-M2-A2-007

模块：M2 | 页码：教材P173

男性,40岁。大量饮酒后昏迷,呕吐物为胃内容物。查体:昏迷状态,瞳孔散大,体温35.5℃,呼吸浅慢(10次/分),血压80/50mmHg,心率120次/分。血乙醇浓度3500mg/L。除常规支持治疗外,应优先使用的药物是

- A. 氟马西尼
- B. 纳洛酮 ☒
- C. 地西泮
- D. 苯巴比妥
- E. 氯丙嗪

答案：B

解析：患者血乙醇浓度大于2500mg/L，处于昏迷期，应诊断为急性重度酒精中毒。纳洛酮0.4~0.8mg静脉注射对昏迷病人有促醒作用。酒精中毒烦躁不安者可用小剂量地西泮，但禁用吗啡、氯丙嗪及巴比妥类镇静药，以免加重呼吸抑制。教材P173。

29. [A3型题 | 应用] batch035-M2-A3-001

模块：M2 | 页码：教材P162-163

男性,30岁。自服农药约100ml后30分钟被家人送来急诊。查体:意识模糊,全身湿冷,双侧瞳孔针尖样缩小,口鼻大量分泌物,呼吸急促,双肺满布湿啰音,可见颜面及四肢肌纤维颤动。该患者最可能的诊断是

- A. 急性有机磷杀虫剂中毒 ☒
- B. 急性氨基甲酸酯类杀虫剂中毒
- C. 急性拟除虫菊酯类杀虫剂中毒
- D. 急性百草枯中毒
- E. 急性毒鼠强中毒

答案：A

解析：患者有明确的农药接触史，出现M样症状（瞳孔针尖样缩小、全身湿冷、口鼻分泌物增多、肺水肿）、N样症状（肌纤维颤动）和中枢神经系统症状（意识模糊），符合急性有机磷中毒的典型表现。氨基甲酸酯类中毒虽也有类似表现但病程较短。教材P162-163。

30. [A3型题 | 应用] batch035-M2-A3-002

模块：M2 | 页码：教材P163

男性,30岁。自服农药约100ml后30分钟被家人送来急诊。查体:意识模糊,全身湿冷,双侧瞳孔针尖样缩小,口鼻大量分泌物,呼吸急促,双肺满布湿啰音,可见颜面及四肢肌纤维颤动。对该患者应首先采取的治疗措施是

- A. 清水洗胃, 并静注阿托品和氯解磷定 ☒
- B. 立即行血液灌流治疗
- C. 先静脉注射地西泮控制抽搐再洗胃
- D. 先完善血胆碱酯酶检查再用药
- E. 先用2%碳酸氢钠洗胃再用药

答案：A

解析：有机磷中毒治疗原则：立即脱离中毒现场、清除毒物（洗胃），同时尽早使用特效解毒药。洗胃一般在服毒后4~6小时内效果最好，应尽早进行。阿托品和胆碱酯酶复活剂应早期、足量、联合、重复用药，不能等待检查结果。由于敌百虫禁用碳酸氢钠洗胃，在不明农药种类时一般用清水洗胃。教材P163。

31. [A3型题 | 分析] batch035-M2-A3-003

模块：M2 | 页码：教材P164

男性,30岁。自服农药后经洗胃、阿托品和氯解磷定治疗后症状缓解。继续治疗中患者出现瞳孔明显扩大、烦躁不安、胡言乱语、尿潴留。此时应首先考虑的处理是

- A. 增加阿托品用量以加强疗效
- B. 立即停用阿托品, 酌情给予毛果芸香碱 ☒
- C. 加用盐酸戊乙奎醚替代阿托品
- D. 增加氯解磷定用量以对抗阿托品中毒
- E. 立即行血液灌流清除毒物

答案：B

解析：患者出现瞳孔明显扩大、烦躁不安、谵妄、尿潴留，提示阿托品中毒，应立即停用阿托品，酌情给予毛果芸香碱对抗，必要时采取血液净化治疗。阿托品中毒是造成有机磷中毒者死亡的重要因素之一，因此要严密观察病人神志、瞳孔、皮肤、心率和肺部啰音变化，及时调整用药。教材P164。

32. [B1型题 | 理解] batch035-M2-B1-001

引起瞳孔明显缩小的急性中毒是

- A. 有机磷杀虫剂中毒 ☒
- B. 阿托品中毒
- C. 甲醇中毒
- D. 乙醇中毒
- E. 氰化物中毒

答案：A

解析：有机磷中毒时乙酰胆碱大量蓄积，与虹膜环形肌的M受体结合，导致瞳孔缩小（严重时呈针尖样）。阿托品中毒瞳孔扩大；甲醇中毒引起视神经炎；乙醇中毒昏迷期可有瞳孔散大；氰化物中毒可见瞳孔扩大。教材P158。[源:考研真题 GS-2019-130]

33. [B1型题 | 记忆] batch035-M2-B1-002

模块：M2 | 页码：教材P158

有机磷杀虫剂中毒时呼出气的气味特征为

- A. 苦杏仁味
- B. 蒜臭味 ☒
- C. 烂苹果味
- D. 苯酚味
- E. 腥臭味

答案：B

解析：有机磷杀虫剂中毒呼出气有蒜味；氰化物中毒有苦杏仁味；苯酚和甲酚皂溶液中毒有苯酚味；糖尿病酮症酸中毒有烂苹果味；肝性脑病有腥臭味。教材P158。[源:考研真题 GS-2018-130]

34. [B1型题 | 理解] batch035-M2-B1-003

模块：M2 | 页码：教材P160

氯酸盐、重铬酸盐中毒易引起急性肾衰竭，应首选的血液净化方式是

- A. 血液透析 ☒
- B. 血液灌流
- C. 血浆置换

- D. CRRT
- E. 腹膜透析

答案：A

解析：血液透析可清除分子量小于500Da、水剪性强、蛋白结合率低的毒物。氯酸盐、重铬酸盐中毒时易引起急性肾衰竭，应首选血液透析。血液灌流对脂剪性强、蛋白结合率高的毒物清除能力强，是急性中毒的首选净化方式。血浆置换主要清除蛋白结合率高的大分子物质。教材P160。

35. [X型题 | 理解] batch035-M2-X-001

模块：M2 | 页码：教材P164

关于急性有机磷杀虫剂中毒解毒药的应用，正确的有

- A. 抗胆碱药首选盐酸戊乙奎醚 ✓
- B. 阿托品能有效解除M样症状和呼吸中枢抑制 ✓
- C. 胆碱酯酶复活剂能有效解除烟碱样症状 ✓
- D. 阿托品对N样症状和呼吸肌麻痹有效
- E. 重度毒须将阿托品胆碱酯酶复活剂联合应用 ✓

答案：ABCE

解析：A对：目前推荐用盐酸戊乙奎醚替代阿托品作为首选抗胆碱药。B对：阿托品主要阻断乙酰胆碱对M受体的作用，能有效解除M样症状及呼吸中枢抑制。C对：胆碱酯酶复活剂能有效解除烟碱样症状，迅速控制肌纤维颤动。D错：阿托品不能阻断N受体，故对N样症状和呼吸肌麻痹所致的周围性呼吸衰竭无效。E对：中重度中毒者必须将阿托品与胆碱酯酶复活剂联合应用，两药合用时应减少阿托品剂量。教材P164。

36. [X型题 | 理解] batch035-M2-X-002

模块：M2 | 页码：教材P159-160

急性中毒的急诊处理原则包括

- A. 立即脱离中毒现场，终止与毒物继续接触 ✓
- B. 检查并稳定生命体征 ✓
- C. 迅速清除体内已被吸收或尚未吸收的毒物 ✓
- D. 如有可能，尽早使用特效解毒药 ✓
- E. 首先完善毒物检测明确诊断再处理

答案：ABCD

解析：急性中毒治疗原则：①立即脱离中毒现场，终止与毒物继续接触；②检查并稳定生命体征；③迅速清除体内已被吸收或尚未吸收的毒物；④如有可能，尽早使用特效解毒药；⑤预防并发症及对症支持治疗。毒物检测虽能帮助确诊，但不能过分依赖，不能因等待检测结果而延误治疗。教材P159-160。

37. [X型题 | 理解] batch035-M2-X-003

模块：M2 | 页码：教材P167

关于急性百草枯中毒的急诊处理，正确的有

- A. 立即用1%~2%碳酸氢钠或温清水洗胃 ✓
- B. 洗胃后注入15%漂白土溶液或活性炭吸附 ✓
- C. 早期大剂量应用糖皮质激素和环磷酰胺 ✓
- D. 尽早行高浓度氧气吸入以改善低氧血症
- E. 及早进行血液灌流治疗加速毒物排泄 ✓

答案：ABCE

解析：A对：立即以1%~2%碳酸氢钠或温清水洗胃，洗胃量不少于5L。B对：洗胃完毕注入15%漂白土溶液或活性炭100g吸附。C对：早期大剂量应用糖皮质激素及环磷酰胺冲击治疗对中重度病人可能有益。D错：高浓度氧气吸入可加重肺组织损害，仅当 $\text{PaO}_2 < 40\text{mmHg}$ 或出现ARDS时才能使用。E对：洗胃完成后应及早进行血液灌流治疗。教材P167。

38. [X型题 | 理解] batch035-M2-X-004

模块：M2 | 页码：教材P161

关于急性中毒特效解毒药的应用，正确的有

- A. 铅中毒首选依地酸钙钠治疗 ✓
- B. 砷、汞中毒可用二巯丙醇等巯基螯合剂 ✓
- C. 亚硝酸盐中毒使用小剂量亚甲蓝 ✓
- D. 氰化物中毒采用亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法 ✓
- E. 氟乙酰胺中毒的特效解毒药是维生素K1

答案：ABCD

解析：A对：依地酸钙钠是最常用的氨羧螯合剂，主要用于治疗铅中毒。B对：二巯丙醇等巯基螯合剂含有活性巯基，主要用于治疗砷、汞、铜、镉等中毒。C对：小剂量亚甲蓝（1

~2mg/kg) 可使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白, 是亚硝酸盐、苯胺等中毒的特效解毒药。D对: 氰化物中毒一般采用亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法。E错: 氟乙酰胺中毒的特效解毒药是乙酰胺, 维生素K1为抗凝血类杀鼠剂的特效药。教材P161。[源: 考研真题 GS-2010-169]

M3 (16题)

39. [A1型题 | 记忆] batch031-M3-A1-001

模块: M3 | 页码: 教材P47

按病程分类, 急性呼吸困难是指病程在3周之内的呼吸困难, 慢性呼吸困难是指病程持续

- A. 1周以上
- B. 2周以上
- C. 3周以上 ☒
- D. 4周以上
- E. 不满3周

答案: C

解析: 教材按病程将呼吸困难分为急性(病程3周以内)与慢性(持续3周以上)两类; 另可按病情分为轻、中、重度, 按病因分为肺源性、心源性、中毒性、血源性、神经精神性等。教材P47。

40. [A1型题 | 理解] batch031-M3-A1-002

模块: M3 | 页码: 教材P48

表现为吸气时胸骨上窝、锁骨上窝及肋间隙凹陷(三凹征)的呼吸困难类型是

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难 ☒
- C. 混合性呼吸困难
- D. 潮式呼吸
- E. 间停呼吸

答案: B

解析: 吸气性呼吸困难多见于喉、气管狭窄(炎症、水肿、异物或肿物压迫), 典型表现为干咳或高调吸气性喘鸣及三凹征; 呼气性呼吸困难多见于支气管哮喘、COPD; 混合性见于重症肺炎、大量胸腔积液等。教材P48。

41. [A1型题 | 记忆] batch031-M3-A1-003

模块：M3 | 页码：教材P60

下列哪项不是ARDS初期的临床表现？

- A. 呼吸频率明显加快
- B. 呼吸窘迫,一般吸氧不缓解
- C. 呼吸道分泌物增多,肺部有啰音 ☒
- D. X线胸片一般无明显异常
- E. PaO₂降至60mmHg

答案：C

解析：ARDS初期表现为呼吸加快、呼吸窘迫感且用一般吸氧法不能缓解、PaO₂降至60mmHg、X线胸片一般无明显异常；呼吸道分泌物增多、肺部有啰音为进展期表现而非初期表现。教材P60。[源:考研真题 GS-1999-082]

42. [A1型题 | 记忆] batch031-M3-A1-004

模块：M3 | 页码：教材P51

支气管哮喘急性发作时，提示病情达危重度的动脉血PaCO₂改变是

- A. <35mmHg
- B. 35~45mmHg
- C. >45mmHg ☒
- D. >60mmHg
- E. >80mmHg

答案：C

解析：按哮喘急性发作病情严重程度分级：轻度PaCO₂<45mmHg、中度≤45mmHg，重度及危重度PaCO₂>45mmHg，危重度还伴pH降低、PaO₂<60mmHg。教材P51。

43. [A1型题 | 记忆] batch031-M3-A1-005

模块：M3 | 页码：教材P54

发生后很快危及生命、需要紧急处理且必须立即抽气减压的气胸类型是

- A. 闭合性气胸

- B. 张力性气胸 ☒
- C. 继发性气胸
- D. 特发性气胸
- E. 单纯性气胸

答案：B

解析：张力性气胸是一种特殊类型的自发性气胸，发生后很快可以危及生命，需要紧急处理，必须立即抽气减压；原发性自发性气胸多由胸膜下肺大疱破裂所致，继发性多在COPD等肺部疾病基础上发生。教材P54。[源:考研真题 GS-2024-062]

44. [A1型题 | 记忆] batch031-M3-A1-006

模块：M3 | 页码：教材P56

急性左心衰竭急诊处理中首选的镇静药是

- A. 地西洋
- B. 吗啡 ☒
- C. 苯巴比妥
- D. 哌替啶
- E. 咪达唑仑

答案：B

解析：急性心衰镇静药首选吗啡，主要作用为抑制中枢交感神经、反射性降低周围血管阻力、扩张静脉减少回心血量，并有减轻焦虑、松弛支气管平滑肌作用；伴明显持续低血压、休克、意识障碍、COPD等病人禁忌使用。教材P56。

45. [A1型题 | 记忆] batch031-M3-A1-007

模块：M3 | 页码：教材P57

引起肺血栓栓塞症（PTE）的血栓主要来源于

- A. 下肢深静脉 ☒
- B. 上肢深静脉
- C. 右心腔
- D. 门静脉系统
- E. 颈内静脉

答案：A

解析：引起PTE的血栓约70%~90%由深静脉血栓脱落后随血液循环进入肺动脉及其分支所致，原发部位以下肢深静脉为主，盆腔静脉血栓是女性肺栓塞的重要来源，极少数来自右心。教材P57。[源:考研真题 GS-2014-096]

46. [A2型题 | 应用] batch031-M3-A2-001

模块：M3 | 页码：教材P60

女性,54岁。急性胰腺炎行胆囊造瘘、胰腺引流术后,予禁食、胃肠减压、输液及抗感染治疗,并吸入高浓度氧。动脉血气分析:pH7.46,PaO₂ 55mmHg,PaCO₂ 33mmHg;X线胸片示两肺较广泛的点、片状阴影;心电图示窦性心动过速。此时提示病人可能存在

- A. 急性心力衰竭
- B. 阻塞性肺部病变
- C. 术后肺不张
- D. 肺部感染
- E. ARDS ☒

答案：E

解析：患者PaO₂<60mmHg、PaCO₂<50mmHg，应诊断为Ⅰ型呼吸衰竭，可首先排除阻塞性肺部病变（COPD常导致Ⅱ型呼吸衰竭）；外科危重病人突发呼吸困难、普通吸氧不能改善、胸片呈斑片状阴影，应诊断为ARDS；急性心力衰竭、肺部感染不会出现如此严重的呼吸困难，两肺广泛点片状阴影亦可排除术后肺不张。教材P60。[源:考研真题 GS-1996-082]

47. [A2型题 | 应用] batch031-M3-A2-002

模块：M3 | 页码：教材P54

男性,68岁。3年前诊断为COPD,未规律治疗。2小时前无明显诱因突感左胸剧痛,继之呼吸困难、发绀、大汗、烦躁。查体:BP90/60mmHg,气管右移,左肺呼吸音减弱,未闻及干、湿啰音。最可能的诊断是

- A. 肺炎并发胸膜炎
- B. 急性肺栓塞
- C. 自发性气胸 ☒
- D. 急性心肌梗死
- E. 大量胸腔积液

答案：C

解析：自发性气胸为COPD的常见并发症，表现为突然加重的呼吸困难、明显发绀、患侧叩诊鼓音、听诊呼吸音减弱或消失、气管向健侧移位；肺炎并发胸膜炎常有肺部湿啰音、无气管移位；肺栓塞常表现为呼吸困难、胸痛、咯血三联征；急性心肌梗死常表现为持续性胸痛。教材P54。[源:考研真题 GS-2013-064]

48. [A2型题 | 应用] batch031-M3-A2-003

模块：M3 | 页码：教材P56

男性,70岁。高血压病史20年。夜间睡眠中突然憋醒,极度呼吸困难,被迫端坐位,咳大量粉红色泡沫痰,大汗淋漓,口唇发绀。听诊双肺满布湿啰音及哮鸣音,心尖部可闻及舒张期奔马律。最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘急性发作
- B. 自发性气胸
- C. 左心衰竭伴肺水肿 ☒
- D. 急性肺栓塞
- E. 急性呼吸窘迫综合征

答案：C

解析：急性肺水肿是急性左心衰最严重的表现，典型表现为突发极度呼吸困难、端坐呼吸、极度烦躁不安、口唇发绀、大汗淋漓、咳大量泡沫样稀薄痰或粉红色泡沫痰，听诊双肺湿啰音或哮鸣音，心尖部可闻及舒张期奔马律。教材P56。

49. [A3型题 | 应用] batch031-M3-A3-001

模块：M3 | 页码：教材P55

男性,26岁。瘦高体型,抬重物时突发右侧胸痛伴胸闷、呼吸困难,疼痛放射到同侧肩部。查体:右侧胸廓饱满,呼吸运动减弱,叩诊呈鼓音,呼吸音减弱,肝、肺浊音界消失。为确立诊断,应首选的检查是

- A. 直立位胸部X线片 ☒
- B. 胸部CT
- C. 心电图检查
- D. 动脉血气分析
- E. 诊断性胸腔穿刺

答案：A

解析：发病时胸部X线影像学检查是诊断气胸最为准确和可靠的方法，条件允许时应选择直立位拍片；仅因病情危重不能立即行胸部X线检查时，才可在胸腔积气体征最明显处进行诊断性穿刺。教材P55。[源:考研真题 GS-2018-070]

50. [A3型题 | 分析] batch031-M3-A3-002

模块：M3 | 页码：教材P60

女性,45岁。重症肺炎3天,进行性呼吸困难加重,已排除心源性肺水肿并行机械通气,PEEP 8cmH₂O,FiO₂ 60%时测得PaO₂ 90mmHg。按PaO₂/FiO₂判断,该病人ARDS的严重程度为

- A. 轻度
- B. 中度 ☒
- C. 重度
- D. 危重度
- E. 不能分级

答案：B

解析：ARDS严重程度采用PaO₂/FiO₂定义（PEEP或CPAP≥5cmH₂O时）：轻度为200mmHg<PaO₂/FiO₂≤300mmHg，中度为100mmHg<PaO₂/FiO₂≤200mmHg，重度为PaO₂/FiO₂≤100mmHg。本例PaO₂/FiO₂=90/0.6=150mmHg，属中度；ARDS分级无危重度（危重度为哮喘分级用语）。教材P60。

51. [B1型题 | 记忆] batch031-M3-B1-001

模块：M3 | 页码：教材P47

按病因分类，支气管哮喘急性发作引起的呼吸困难属于

- A. 肺源性 ☒
- B. 心源性
- C. 中毒性
- D. 血源性
- E. 神经精神性

答案：A

解析：按病因呼吸困难分为肺源性、心源性、中毒性、血源性、神经精神性及其他；肺源性呼吸困难又分为呼气性、吸气性和混合性，支气管哮喘属肺源性。教材P47。

52. [B1型题 | 理解] batch031-M3-B1-002

模块：M3 | 页码：教材P47

按病因分类，糖尿病酮症酸中毒引起的呼吸困难属于

- A. 肺源性
- B. 心源性
- C. 中毒性
- **D. 血源性** ✓
- E. 神经精神性

答案：D

解析：表4-1中血源性呼吸困难的常见疾病包括重度贫血、高铁血红蛋白血症、甲状腺危象、糖尿病酮症酸中毒、急性大出血等；中毒性常见于CO、药物中毒及毒蛇咬伤。教材P47。

53. [X型题 | 理解] batch031-M3-X-001

模块：M3 | 页码：教材P61

急性呼吸窘迫综合征机械通气治疗的原则有

- A. 采用较大潮气量，保证PaCO₂正常
- **B. 给予适当水平PEEP，开放萎陷肺泡** ✓
- C. 初始上机即给予高水平PEEP
- **D. 吸气平台压控制在30~35cmH₂O以下** ✓
- E. 常规抗凝治疗预防肺损伤

答案：BD

解析：A错：应采用小潮气量6~8ml/kg（理想体重），可允许一定程度的CO₂潴留；B对：充分复张塌陷肺泡后应用适当水平PEEP防止呼气末肺泡塌陷，改善低氧血症；C错：PEEP应从较低水平开始逐渐调至合适水平；D对：气道平台压应<30cmH₂O，防止肺泡过度扩张及机械通气相关性肺损伤；E错：ARDS除非合并DIC，一般不常规抗凝。教材P61。[源:考研真题 GS-2019-154]

54. [X型题 | 理解] batch031-M3-X-002

模块：M3 | 页码：教材P53

关于支气管哮喘急性发作的急诊处理，正确的有

- A. 缓解症状首选吸入SABA ☒
- B. 第1小时内SABA可每20分钟重复1次 ☒
- C. 哮喘急性发作时应禁用镇静药 ☒
- D. 全身激素首选地塞米松静滴
- E. 面罩吸氧使血氧饱和度92%以上 ☒

答案：ABCE

解析：A对：吸入短效 β_2 受体激动剂（沙丁胺醇、特布他林等）是缓解轻中度以上急性哮喘症状的首选药物；B对：第1小时内20分钟重复1次，亦可用雾化吸入溶液；C对：哮喘紧急处理须禁用镇静药；D错：地塞米松血浆和组织半衰期长、对脑垂体-肾上腺轴抑制时间长，应尽量避免使用，严重哮喘首选甲泼尼龙或琥珀酸氢化可的松；E对：可用面罩大流量吸氧，保持血氧饱和度在92%以上（儿童 $\geq 95\%$ ），但不宜给纯氧。教材P53。

M4（26题）

55. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-001

模块：M4 | 页码：教材P14

晕厥是一过性全脑低灌注导致的短暂性意识丧失，典型晕厥发作持续时间一般不超过

- A. 10秒
- B. 20秒 ☒
- C. 30秒
- D. 40秒
- E. 60秒

答案：B

解析：晕厥的特点为突然、短暂和自行完全恢复，典型晕厥发作持续时间一般不超过20秒，少数可持续数分钟。教材P14。

56. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-002

模块：M4 | 页码：教材P15

有助于诊断血管迷走性晕厥的检查是

- A. 直立倾斜试验 ☒
- B. 颈动脉窦按摩试验
- C. 卧位起立试验

- D. 冠状动脉造影
- E. 腰椎穿刺

答案：A

解析：血管迷走性晕厥以青年女性、体质虚弱者常见，直立倾斜试验阳性；颈动脉窦按摩试验用于颈动脉窦性晕厥；卧位起立试验用于直立性低血压性晕厥。教材P15。

57. [A1型题 | 理解] batch031-M4-A1-003

模块：M4 | 页码：教材P17

下列疾病中，最可能先出现意识障碍后发热的是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 重症中暑
- C. 有机磷农药中毒 ☒
- D. 中毒性细菌性痢疾
- E. 流行性脑脊髓膜炎

答案：C

解析：先发热后昏迷见于流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、中毒性菌痢、中暑、斑疹伤寒等；先昏迷后发热见于脑出血、巴比妥类药物中毒、有机磷农药中毒等。教材P17（昏迷常见病因表3-2）。[源:考研真题 GS-2023-041]

58. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-004

模块：M4 | 页码：教材P18

格拉斯哥昏迷量表（GCS）评分中，提示有潜在死亡危险的分值范围是

- A. 3~5分 ☒
- B. 6~8分
- C. 9~11分
- D. 12~14分
- E. 15分

答案：A

解析：GCS根据睁眼、言语、运动三项反应评分，最高15分（无昏迷），最低3分，分数越低昏迷越深；通常8分以上恢复机会较大，7分以下预后不良，3~5分者有潜在死亡危险。教材P18。

59. [A1型题 | 理解] batch031-M4-A1-005

模块：M4 | 页码：教材P19

昏迷病人查体发现鼾式呼吸，最应考虑的疾病是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 尿毒症昏迷
- C. 脑出血昏迷 ☒
- D. 肝性脑病
- E. 镇静催眠药中毒

答案：C

解析：鼾式呼吸见于脑出血；呼吸深长（Kussmaul呼吸）伴烂苹果味见于糖尿病酮症酸中毒、尿有氨味见于尿毒症昏迷；浅而慢的呼吸见于镇静催眠药及成瘾性药物中毒；肝性脑病呼气有肝臭味。教材P19。

60. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-006

模块：M4 | 页码：教材P23

绝大多数高血压脑出血发生的部位是

- A. 大脑皮质
- B. 脑干脑桥
- C. 基底节区及内囊 ☒
- D. 小脑齿状核
- E. 丘脑区域

答案：C

解析：绝大多数高血压脑出血发生在基底核的壳核及内囊区（约占70%），脑叶、脑干及小脑齿状核出血各占约10%。教材P23。

61. [A1型题 | 理解] batch031-M4-A1-007

模块：M4 | 页码：教材P24

脑桥出血病人最具特征性的瞳孔改变是

- A. 双侧瞳孔散大固定

- B. 双侧瞳孔缩小呈针尖样 ☒
- C. 双侧瞳孔不等大
- D. 一侧瞳孔散大伴对光反射消失
- E. 瞳孔大小无异常改变

答案：B

解析：脑桥出血常迅速出现深昏迷，瞳孔明显缩小呈针尖样，但对光反射存在；四肢瘫痪，双侧锥体束征阳性，高热，呼吸不规则，血压不稳。教材P24。

62. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-008

模块：M4 | 页码：教材P29

急性脑梗死使用rt-PA（重组组织型纤溶酶原激活剂）静脉溶栓的时间窗为发病后

- A. 3小时以内
- B. 3~4.5小时 ☒
- C. 6小时以内
- D. 8小时以内
- E. 12小时以内

答案：B

解析：早期溶栓适应证规定：发病3~4.5小时以内使用rt-PA，6小时以内使用尿激酶；rt-PA一次用量0.9mg/kg（最大90mg）。教材P29。

63. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-009

模块：M4 | 页码：教材P31

自发性蛛网膜下腔出血最常见的病因是

- A. 高血压脑动脉硬化
- B. 颅内肿瘤卒中
- C. 先天性动脉瘤破裂 ☒
- D. 血液系统疾病
- E. 颅内静脉血栓形成

答案：C

解析：自发性蛛网膜下腔出血最常见的病因为先天性动脉瘤和动静脉畸形破裂（约占75%~80%），其次是高血压脑出血（约占15%）；40岁以后发病者多为颅内动脉瘤破裂。教材

64. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-010

模块：M4 | 页码：教材P34

正常人血糖浓度低于下列哪项可考虑低血糖症

- A. $<2.5\text{mmol/L}$
- **B. $<2.8\text{mmol/L}$** ✓
- C. $<3.36\text{mmol/L}$
- D. $<3.9\text{mmol/L}$
- E. $<4.4\text{mmol/L}$

答案：B

解析：低血糖症指正常人血中葡萄糖浓度 $<2.8\text{mmol/L}$ ，或糖尿病病人血糖浓度 $<3.9\text{mmol/L}$ ；典型者具有Whipple三联征。教材P34。

65. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-011

模块：M4 | 页码：教材P46

全身强直-阵挛性发作持续状态控制抽搐的首选药物是

- A. 苯妥英钠
- **B. 地西泮** ✓
- C. 苯巴比妥
- D. 利多卡因
- E. 氯硝西泮

答案：B

解析：癫痫持续状态处理原则为迅速控制抽搐、立即终止发作，地西泮为首选药物，成人每次 $10\sim 20\text{mg}$ ，以 $2\sim 5\text{mg/min}$ 速度静脉注射， $15\sim 20$ 分钟后可重复给药。教材P46。

66. [A1型题 | 记忆] batch031-M4-A1-012

模块：M4 | 页码：教材P39

高渗性高血糖状态（HHS）实验室诊断的血浆有效渗透压参考标准是

- A. $\geq 280\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
- B. $\geq 300\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
- C. $\geq 310\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
- **D. $\geq 320\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$** ✓
- E. $\geq 350\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$

答案：D

解析：HHS实验室诊断参考标准：血糖 $\geq 33.3\text{mmol/L}$ ，有效血浆渗透压 $\geq 320\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ （正常范围280~310）；当渗透压 > 320 时即可出现淡漠、嗜睡， > 350 时可有幻觉、定向力障碍甚至昏迷。教材P39。

67. [A2型题 | 应用] batch031-M4-A2-001

模块：M4 | 页码：教材P17

男性,82岁。因脑出血4小时行开颅减压手术后意识不清,对声、光刺激无反应,尚可对疼痛刺激有反应,角膜反射、吞咽反射存在。对该患者意识状态的判断,正确的是

- A. 昏睡
- **B. 轻度昏迷** ✓
- C. 中度昏迷
- D. 深度昏迷
- E. 意识模糊

答案：B

解析：轻度昏迷指意识大部分丧失，无自主运动，对声、光刺激无反应，对疼痛刺激尚可出现防御反应，角膜反射、瞳孔对光反射、吞咽反射等可存在；中度昏迷对剧烈刺激可出现防御反射但角膜反射减弱；深度昏迷对各种刺激全无反应，深、浅反射均消失。教材P17。[源:考研真题 GS-2024-042]

68. [A2型题 | 应用] batch031-M4-A2-002

模块：M4 | 页码：教材P36

男性,20岁。近半年乏力、体重下降约15kg,食欲尚可,尿量多。2天前外出就餐后恶心、腹痛伴腹泻,1天来精神恍惚。既往曾查血糖高。查体:T 36.8°C ,P118次/分,R28次/分,BP88/58mmHg,嗜睡,呼吸深快,皮肤干燥,四肢发凉。最可能的诊断是

- A. 甲状腺危象
- **B. 糖尿病酮症酸中毒** ✓

- C. 感染中毒性休克
- D. 急性食物中毒
- E. 高渗性高血糖状态

答案：B

解析：患者无高热，可排除甲状腺危象、感染中毒性休克（二者多有高热）；青年男性、乏力消瘦、多尿、既往血糖增高，考虑糖尿病；进食后腹泻、精神恍惚、呼吸深快（Kussmaul呼吸）、脱水征、四肢发凉，应诊断为糖尿病酮症酸中毒。教材P36。[源:考研真题 GS-2019-055]

69. [A2型题 | 应用] batch031-M4-A2-003

模块：M4 | 页码：教材P39

女性,72岁。口渴、多饮、多尿1个月,近1天反应迟钝、嗜睡来诊。查体明显脱水貌。急查血糖35.3mmol/L,尿酮体弱阳性,无深大呼吸。最可能的诊断是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 高血糖高渗状态 ☒
- C. 急性胃肠炎伴血糖升高
- D. 水电解质紊乱
- E. 乳酸酸中毒

答案：B

解析：急查血糖高达35.3mmol/L，可首先排除急性胃肠炎合并脱水、水电解质紊乱（血糖不会如此显著增高）；DKA血糖多为16.7~33.3mmol/L，常伴Kussmaul呼吸；HHS血糖多≥33.3mmol/L、无Kussmaul呼吸、无明显酮症酸中毒，本例符合HHS。教材P39。[源:考研真题 GS-2015-108]

70. [A2型题 | 应用] batch031-M4-A2-004

模块：M4 | 页码：教材P44

女性,38岁。甲状腺大部切除术后1天出现手足持续性痉挛,伴口周麻木、指尖针刺感。为明确诊断,首选的检查是

- A. 血T3、T4
- B. 颈部B超
- C. 颈部穿刺
- D. 血清钙、磷浓度 ☒

- E. 颈部CT

答案：D

解析：手足持续性痉挛伴口周麻木提示低钙血症（术后甲状旁腺损伤致PTH分泌减少），诊断低钙血症的血清总钙 $<2.25\text{mmol/L}$ （须经血清白蛋白校正），故首选血清钙、磷浓度测定；血T3、T4用于甲状腺功能评估，颈部B超、CT用于甲状腺形态学检查。教材P44。[来源：考研真题 GS-2015-116]

71. [A2型题 | 应用] batch031-M4-A2-005

模块：M4 | 页码：教材P44

男婴,2岁。发热、流涕1天,体温 39°C ,就诊时突发全身性抽搐,持续约3分钟自行停止,发作后很快清醒,查体无神经系统异常体征,24小时内仅发作1次。最可能的诊断是

- A. 单纯性高热抽搐 ☒
- B. 复杂性高热抽搐
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 癫痫发作
- E. 低钙性抽搐

答案：A

解析：单纯性高热抽搐：首次发作多在6月龄至3岁之间，发热24小时内出现，体温 $>38^{\circ}\text{C}$ ，发作呈全身性，持续时间一般不超过10分钟，发作后很快清醒且无神经系统体征，24小时内只发作一次；复杂性高热抽搐发作年龄 <6 月龄或 >6 岁，发作持续超过15分钟，呈局限性发作，24小时内可反复发作。教材P44。

72. [A2型题 | 应用] batch031-M4-A2-006

模块：M4 | 页码：教材P36

女性,68岁。糖尿病病史12年,晨起注射胰岛素后未进食,家属发现其呼之不应送来急诊。急查血糖 1.9mmol/L 。应立即采取的处理措施是

- A. 静注50%葡萄糖40~60ml ☒
- B. 静脉滴注0.9%氯化钠溶液
- C. 肌肉注射胰高血糖素1mg
- D. 快速静脉注射甘露醇
- E. 静脉注射地西泮10mg

答案：A

解析：低血糖症急诊处理应立刻补充葡萄糖，对昏迷者首剂静脉注射50%葡萄糖40～60ml，然后继续用5%～10%葡萄糖静脉滴注，多数病人迅速清醒；中枢神经系统血糖恢复正常的时间滞后于其他组织，应持续输注葡萄糖数小时以免再次发生低血糖；胰高血糖素仅适用于不能迅速建立静脉通道的病人。教材P36。

73. [A3型题 | 应用] batch031-M4-A3-001

模块：M4 | 页码：教材P24

男性,65岁。高血压病史15年,打麻将时突发头痛、呕吐,随即言语含糊,右侧肢体无力。查体:BP200/110mmHg,嗜睡,双眼向左侧凝视,右侧中枢性面瘫、右侧肢体偏瘫,右侧偏身感觉减退。最可能的出血部位是

- A. 左侧壳核-内囊 ☒
- B. 右侧壳核内囊左侧
- C. 丘脑区域
- D. 脑桥出血
- E. 小脑半球

答案：A

解析：壳核-内囊为临床最常见出血部位，出血病灶对侧常出现偏瘫、偏侧感觉障碍与偏盲的三偏综合征，双眼向病灶侧凝视（凝视病灶），优势半球病变可有失语。本例右侧偏瘫伴双眼向左凝视，提示左侧壳核-内囊出血。教材P24。

74. [A3型题 | 应用] batch031-M4-A3-002

模块：M4 | 页码：教材P26

男性,65岁。高血压病史15年,打麻将时突发头痛、呕吐,随即言语含糊,右侧肢体无力。查体:BP200/110mmHg,嗜睡,双眼向左侧凝视,右侧中枢性面瘫、右侧肢体偏瘫。为尽快明确诊断，应首选的检查是

- A. 颅脑MRI
- B. 脑血管造影
- C. 腰椎穿刺
- D. 颅脑CT扫描 ☒
- E. 脑电图

答案：D

解析：颅脑CT检查对脑出血的诊断率几乎可达100%，既是有效的诊断方法，也是制订治疗方案、观察疗效、判断预后的重要依据，是急性脑出血的首选检查；MRI诊断亚急性与慢性血肿比CT敏感；脑血管造影用于怀疑AVM或脑动脉瘤破裂出血时明确病因。教材P26。

75. [A3型题 | 分析] batch031-M4-A3-003

模块：M4 | 页码：教材P29

女性,70岁。持续性心房颤动病史10年。3小时前突发言语不清伴右侧肢体无力。查体:BP170/95mmHg,神志清楚,运动性失语,右侧中枢性面舌瘫,右上肢肌力2级。急查颅脑CT未见高密度出血灶,亦未见大片低密度病灶。凝血功能正常,无近期手术、外伤及出血病史。下一步最适宜的治疗是

- A. rt-PA静脉溶栓 ☒
- B. 尿激酶静脉溶栓
- C. 低分子量肝素抗凝
- D. 静脉滴注甘露醇
- E. 去骨瓣减压术

答案：A

解析：患者有房颤病史（心源性栓子来源）、突发起病，符合脑栓塞；发病3小时，在rt-PA时间窗（3~4.5小时）内，年龄 ≥ 18 岁，血压170/95mmHg未超过溶栓禁忌（收缩压 ≥ 180 mmHg或舒张压 ≥ 110 mmHg），CT排除脑出血及大片低密度灶，无出血倾向及近期手术史，具备rt-PA静脉溶栓适应证；尿激酶时间窗为6小时以内但rt-PA为当前首选再灌注方案；抗凝治疗一般不推荐急性期应用。教材P29。

76. [B1型题 | 记忆] batch031-M4-B1-001

模块：M4 | 页码：教材P15

各种原因（包括药物）导致的心室率 < 40 次/分的心动过缓所引起的晕厥属于

- A. 反射性晕厥
- B. 心源性晕厥 ☒
- C. 脑源性晕厥
- D. 低血糖性晕厥
- E. 严重贫血性晕厥

答案：B

解析：心源性晕厥包括心律失常致晕厥和器质性心脏病致晕厥；各种原因（包括药物）导致的心动过缓（心室率 <40 次/分）和快速性室性心律失常（心率 >130 次/分）均可引起急性脑缺血而发生晕厥。教材P15。

77. [B1型题 | 理解] batch031-M4-B1-002

模块：M4 | 页码：教材P15

青年女性,体质虚弱,激动、恐惧后于直立位发作晕厥,发作前有头晕、面色苍白、出汗等先兆,血压迅速下降、心率减慢,直立倾斜试验阳性。其晕厥类型属于

- A. 反射性晕厥 ☒
- B. 心源性晕厥
- C. 脑源性晕厥
- D. 低血糖性晕厥
- E. 严重贫血性晕厥

答案：A

解析：血管迷走性晕厥属反射性晕厥，以青年女性、体质虚弱者常见，诱发因素包括激动、恐惧、焦虑、剧痛等，多在直立位或坐位时诱发，发病前有先兆症状，直立倾斜试验阳性。教材P15。[源:考研真题 GS-2010-057]

78. [X型题 | 理解] batch031-M4-X-001

模块：M4 | 页码：教材P17

引起昏迷的常见病因包括

- A. 低血糖症 ☒
- B. 高钠血症 ☒
- C. 黏液性水肿昏迷 ☒
- D. 帕金森病
- E. 脓毒症脑病 ☒

答案：ABCE

解析：A对：血糖异常（低血糖、糖尿病酮症酸中毒、高渗性高血糖状态）是昏迷的常见病因；B对：电解质与酸碱平衡紊乱（高钠/低钠血症、酸碱中毒、高低钾血症等）可致昏迷；C对：内分泌疾病（黏液性水肿昏迷、甲状腺危象、垂体危象等）可致昏迷；D错：帕金森病一般不直接引起昏迷；E对：感染性休克（脓毒症）、中枢神经系统感染均可致昏迷。教材P17。

79. [X型题 | 理解] batch031-M4-X-002

模块：M4 | 页码：教材P27

关于脑出血急性期的内科治疗，正确的有

- A. 收缩压 $>200\text{mmHg}$ 时持续静脉降压 ✓
- B. 甘露醇 $0.25\sim0.5\text{g/kg}$ ，q6h ✓
- C. 烦躁者可用地西泮，禁用吗啡 ✓
- D. 多数病人应常规使用止血药
- E. 壳核出血 $>30\text{ml}$ 应行手术治疗 ✓

答案：ABCE

解析：A对：收缩压 $>200\text{mmHg}$ 或平均动脉压 $>150\text{mmHg}$ 时，要持续应用静脉降压药物积极降低血压；B对：控制脑水肿可使用3%高渗盐水或甘露醇 $0.25\sim0.5\text{g/kg}$ ，每6小时一次；C对：如烦躁不安，可用地西泮类药物，禁用吗啡类药物；D错：除有出血倾向和并发消化道出血的病人可适当应用止血药物外，多数病人不必常规使用；E对：壳核出血 $>30\text{ml}$ 、丘脑出血 $>15\text{ml}$ 、小脑半球出血 $>10\text{ml}$ 或直径 $\geq 3\text{cm}$ 等应行手术治疗。教材P27。

80. [X型题 | 理解] batch031-M4-X-003

模块：M4 | 页码：教材P46

关于癫痫持续状态控制抽搐的用药，正确的有

- A. 控制抽搐首选地西泮静脉注射 ✓
- B. 地西泮以 $2\sim5\text{mg/min}$ 速度静注 ✓
- C. 地西泮 $15\sim20$ 分钟后可重复给药 ✓
- D. 苯妥英钠静注速度不超过 25mg/min ✓
- E. 咪达唑仑起效缓慢，数小时方起效

答案：ABCD

解析：A对：全身强直-阵挛性发作持续状态首选地西泮，成人每次 $10\sim20\text{mg}$ ；B对：以 $2\sim5\text{mg/min}$ 的速度静脉注射；C对： $15\sim20$ 分钟后可重复给药，总量不超过 $100\sim200\text{mg}$ ；D对：苯妥英钠成人首次 $150\sim250\text{mg}$ ，静脉注射速度不超过 25mg/min ，以免发生低血压、心律失常；E错：咪达唑仑起效快，但有抑制呼吸、引起低血压的作用。教材P46。

M5 (24题)

81. [A1型题 | 记忆] batch031-M5-A1-001

模块：M5 | 页码：教材P148

休克最基本的病理生理改变是

- A. 有效循环血容量减少，组织微循环灌注不足 ☒
- B. 心输出量显著下降，外周血管扩张
- C. 冠状动脉血流减少，心肌收缩力降低
- D. 细胞外液总量显著增多，组织水肿
- E. 动脉血氧饱和度进行性下降

答案：A

解析：休克是由各种致病因素引起的有效循环血容量急剧减少，导致器官和组织微循环灌注不足，致使组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损的综合征。参阅教材P148。

82. [A1型题 | 记忆] batch031-M5-A1-002

模块：M5 | 页码：教材P154

成人休克指数（脉率/收缩压）为1.0时，估计失血量约为全身血量的

- A. 10%以下
- B. 20%~30% ☒
- C. 30%~50%
- D. 50%~70%
- E. 70%以上

答案：B

解析：休克指数（脉率/收缩压）为0.5表明血容量正常或失血量不超过10%；为1.0时失血量约为20%~30%；为1.5时失血量约为30%~50%。参阅教材P154。

83. [A1型题 | 记忆] batch031-M5-A1-003

模块：M5 | 页码：教材P154

心源性休克病人血流动力学指标的典型改变是

- A. $CI < 1.5$ ， $PAWP < 8$
- B. $CI < 2.2$ ， $PAWP > 18$ ☒
- C. $CI 2.5 \sim 4$ ， $PAWP 12 \sim 18$

- D. $CI > 4.0$, $PAWP < 10$
- E. CI正常, $PAWP > 25$

答案：B

解析：心源性休克时心脏指数（CI） $< 2.2L/(min \cdot m^2)$ ，肺动脉楔压（PAWP） $> 18mmHg$ ；CI正常值为 $2.5 \sim 4.0L/(min \cdot m^2)$ 。参阅教材P154、P151。

84. [A1型题 | 记忆] batch031-M5-A1-004

模块：M5 | 页码：教材P153

治疗感染性休克最理想的血管活性药物方案是

- A. 多巴胺联合间羟胺
- B. 肾上腺素联合多巴胺
- C. 多巴酚丁胺联合毛花苷C
- D. 去甲肾上腺素联合多巴酚丁胺 ☒
- E. 去甲肾上腺素联合纳洛酮

答案：D

解析：去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克最理想的血管活性药物治疗方案；多巴胺是最常用的血管活性药，抗休克时宜采取小剂量。参阅教材P153。

85. [A1型题 | 理解] batch031-M5-A1-005

模块：M5 | 页码：教材P155

感染性休克中，暖休克多见于

- A. 革兰氏阴性杆菌感染
- B. 深部真菌感染
- C. 病毒性感染
- D. 立克次体感染
- E. 革兰氏阳性球菌感染 ☒

答案：E

解析：暖休克多见于革兰氏阳性球菌感染，表现为意识清醒、皮肤潮红、不湿不凉、脉搏可触及、脉压 $> 30mmHg$ 、尿量 $> 30ml/h$ ；冷休克多见于革兰氏阴性杆菌感染。参阅教材P155。

86. [A1型题 | 记忆] batch031-M5-A1-006

模块：M5 | 页码：教材P155

接触过敏原后发生过敏性休克，若不及时抢救，重者可在多长时间内死亡

- A. 1小时内
- B. 2分钟内
- C. 3小时内
- **D. 10分钟内** ✓
- E. 30分钟内

答案：D

解析：过敏性休克是一种极为严重的过敏反应，若不及时抢救，重者可在10分钟内死亡；常在接触过敏原后15分钟内发生严重反应，少数可在30分钟甚至数小时后发生，称迟发性反应。参阅教材P155。

87. [A1型题 | 记忆] batch031-M5-A1-007

模块：M5 | 页码：教材P154

失血性休克病人，血红蛋白浓度低于多少时可以输注浓缩红细胞

- **A. 70g/L** ✓
- B. 80g/L
- C. 90g/L
- D. 100g/L
- E. 120g/L

答案：A

解析：一般认为血红蛋白浓度高于100g/L不必输血；低于70g/L可输浓缩红细胞；在70～100g/L时，根据出血是否停止、一般情况、代偿能力和其他重要器官功能决定是否输红细胞。参阅教材P154。

88. [A1型题 | 理解] batch031-M5-A1-008

模块：M5 | 页码：教材P148

下列关于休克的叙述，哪项是正确的？

- A. 迅速失血超全身总血量10%时即出现休克
- B. 失血性休克应输入葡萄糖溶液再大量输血
- C. 损伤性休克不属于低血容量性休克
- **D. 感染性休克多是革兰阴性杆菌释放内毒素引起** ✓
- E. 感染性休克的治疗原则是首先控制感染

答案：D

解析：①短期内失血超过全身总血量的20%时可出现休克。②抢救失血性休克时可首先快速输入平衡盐液，继之输血。③创伤和失血引起的休克归为低血容量性休克。④革兰阴性杆菌性休克多由内毒素引起，D正确。⑤休克的治疗原则首先是补充血容量，感染性休克也不例外。[源:考研真题 GS-2003-076]

89. [A1型题 | 理解] batch031-M5-A1-009

模块：M5 | 页码：教材P149

下列选项中，对休克的微循环变化和内脏继发性损害较严重的是

- A. 心源性休克
- B. 低血容量性休克
- **C. 感染性休克** ✓
- D. 过敏性休克
- E. 神经源性休克

答案：C

解析：感染性休克的致病菌大多为革兰阴性杆菌，其释放的内毒素可刺激交感神经引起血管痉挛并损害血管内皮细胞，促使组胺、激肽、前列腺素等炎症介质释放，引起全身炎症反应，导致微循环障碍、代谢紊乱及器官功能不全；其余类型休克无内毒素释放，对内脏的继发性损害相对较轻。[源:考研真题 GS-2007-087]

90. [A1型题 | 理解] batch031-M5-A1-010

模块：M5 | 页码：教材P149

休克早期微循环的主要变化是

- A. 毛细血管前阻力显著降低
- **B. 交感神经肾上腺髓质兴奋,微循环以收缩为主** ✓
- C. 毛细血管网大量开放、淤血
- D. 微血栓广泛形成微循环

- E. 血管床容积显著增大，血压进行性下降

答案：B

解析：休克早期有效循环血容量减少，反射性引起交感神经-肾上腺髓质系统兴奋，使心率加快、心肌收缩力增强、小血管收缩，周围血管阻力增加以维持血压；毛细血管内流体静压降低有利于液体进入血管，增加回心血量。淤血、微血栓形成见于失代偿期及DIC阶段。参阅教材P149。

91. [A1型题 | 应用] batch031-M5-A1-011

模块：M5 | 页码：教材P153

休克病人快速补液过程中，中心静脉压监测明显 $>12\text{cmH}_2\text{O}$ 时，应警惕发生

- A. 急性肾损伤
- B. 心律失常
- C. 颅内压增高
- **D. 肺水肿** 
- E. 脑水肿

答案：D

解析：动脉血压和中心静脉压是简便客观的补液监护指标，当中心静脉压明显 $>12\text{cmH}_2\text{O}$ 时，应警惕发生肺水肿。参阅教材P153。

92. [A2型题 | 应用] batch031-M5-A2-001

模块：M5 | 页码：教材P154

男性，30岁，腹部刀刺伤2小时。查体：面色苍白，四肢湿冷，脉搏120次/分，收缩压80mmHg。按休克指数估计，其失血量约为全身血量的

- A. 10%以下
- B. 20%~30%
- **C. 30%~50%** 
- D. 50%~70%
- E. 70%以上

答案：C

解析：休克指数=脉率/收缩压=120/80=1.5，提示失血量约为30%~50%；休克指数1.0约为20%~30%，0.5为血容量正常或失血不超过10%。参阅教材P154。

93. [A2型题 | 应用] batch031-M5-A2-002

模块：M5 | 页码：教材P154

男性，78岁。6小时前在睡眠中突发胸痛，有明显压迫感，自含硝酸甘油2片，症状稍有缓解。2小时前胸痛再次加重，持续不缓解伴呼吸困难而来院。既往有高血压病20年，糖尿病18年。查体：R20次/分，BP88/50mmHg，口唇发绀，双肺满布湿啰音，心率106次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮肤湿凉。心电图示V2~V6、I、aVL导联ST段水平下移0.2~0.4mV，T波倒置，cTnT 1.58μg/L。对该患者应采取的治疗措施是

- A. 即刻静脉补液扩容，提升血压BP
- B. 在使用升压药的同时，即刻溶栓治疗
- C. 即刻在置入IABP同时行冠脉介入治疗 ✓
- D. 即刻给予血管扩张剂及利尿剂，控制心衰
- E. 即刻静脉注射毛花苷C纠正心力衰竭

答案：C

解析：①老年患者突发胸痛，硝酸甘油疗效差，心电图多导联ST段压低超过0.1mV、T波倒置，肌钙蛋白T增高，应考虑非ST段抬高型心肌梗死（NSTEMI）。患者血压<90/60mmHg，心率增快，心音低钝，四肢末梢皮肤湿凉，应考虑休克，故诊断为NSTEMI合并心源性休克。②为降低心源性休克的病死率，应立即置入主动脉内球囊反搏（IABP）进行辅助循环，同时行冠状动脉介入治疗。③A为休克的一般性治疗措施，B、D、E并不适合NSTEMI合并心源性休克的治疗。[源：考研真题 GS-2024-046]

94. [A2型题 | 应用] batch031-M5-A2-003

模块：M5 | 页码：教材P155

女性，65岁，急性胆管炎伴寒战、高热12小时。查体：血压78/45mmHg，心率125次/分，皮肤湿冷呈花斑状，血乳酸4.8mmol/L。该病人初始液体复苏应

- A. 按30ml/kg的标准快速补充等渗晶体液 ✓
- B. 按10ml/kg的标准限制性补液
- C. 立即输注全血1 000ml
- D. 先用升压药将血压提至正常后再补液
- E. 按100ml/kg的标准快速补液

答案：A

解析：感染性休克病人对于低血压（平均动脉压<65mmHg）或血乳酸≥4mmol/L者，应按30ml/kg的标准进行液体复苏。本例平均动脉压约56mmHg、血乳酸4.8mmol/L，符合复苏指征。参阅教材P155。

95. [A2型题 | 应用] batch031-M5-A2-004

模块：M5 | 页码：教材P155

女性，25岁，静脉滴注青霉素5分钟后出现全身荨麻疹、喉部发紧、呼吸困难，血压70/40mmHg。首要的急救处理是

- A. 快速静脉补液扩容
- B. 静脉注射地塞米松
- C. 肌肉注射异丙嗪
- D. 雾化吸入支气管扩张剂
- E. 立即停药并肌肉注射肾上腺素 ☒

答案：E

解析：过敏性休克必须立即去除过敏原（药物过敏时需立即停药），保持呼吸道通畅、吸氧，立即注射肾上腺素（首选肌肉注射），同时给予糖皮质激素、升压药、抗组胺药等。参阅教材P155。

96. [A2型题 | 应用] batch031-M5-A2-005

模块：M5 | 页码：教材P152

男性，72岁，呕吐、腹泻2天，少尿，精神萎靡。查体：心率115次/分，血压84/60mmHg，皮肤弹性差。即刻应采取的处理措施是

- A. 快速补液加升压药 ☒
- B. 增强CT
- C. 血管造影
- D. 减慢心率
- E. 留置导尿监测尿量

答案：A

解析：病人心率增快、血压84/60mmHg，应考虑休克，故首选治疗为补充血容量；不宜在休克状态下做过多的影像学检查（增强CT、血管造影等），以免贻误抢救时机；心率增快系循环血容量不足所致，补足血容量后心率将减慢。参阅教材P152。[源:考研真题 GS-2013-111]

97. [A3型题 | 应用] batch031-M5-A3-001

男性，45岁，车祸伤致左上腹痛、心悸2小时入院。查体：神志淡漠，面色苍白，四肢湿冷发凉，脉搏110次/分，血压85/65mmHg，腹部移动性浊音阳性，腹腔穿刺抽出不凝血液，留置导尿示尿量约20ml/h。该病人休克的程度为

- A. 休克代偿期（轻度）
- **B. 休克失代偿期（中度）** ☒
- C. 休克失代偿期（重度）
- D. 神经源性休克
- E. 感染性休克

答案：B

解析：中度（失代偿期）休克表现为神志尚清楚但表情淡漠、很口渴、皮肤苍白发冷、脉搏100~200次/分、收缩压70~90mmHg且脉压小、少尿，估计失血量20%~40%。重度休克收缩压在70mmHg以下或测不到、意识模糊甚至昏迷、少尿或无尿；本例血压85/65mmHg、神志淡漠，符合中度。参阅教材P150。

98. [A3型题 | 应用] batch031-M5-A3-002

男性，45岁，车祸伤致左上腹痛、心悸2小时入院。查体：神志淡漠，面色苍白，四肢湿冷发凉，脉搏110次/分，血压85/65mmHg，腹部移动性浊音阳性，腹腔穿刺抽出不凝血液，留置导尿示尿量约20ml/h。估计该病人的失血量约为

- A. 10%以下（400ml以下）
- B. 10%~20%（400~800ml）
- **C. 20%~40%（800~1 600ml）** ☒
- D. 40%~50%（1600~2000ml）
- E. 50%以上（2 000ml以上）

答案：C

解析：休克失代偿期中度者估计失血量为20%~40%（800~1 600ml）；轻度（代偿期）在20%以下（800ml以下），重度在40%以上（1 600ml以上），此标准针对成人低血容量性休克。参阅教材P150。

99. [A3型题 | 分析] batch031-M5-A3-003

男性，45岁，车祸伤致左上腹痛、心悸2小时入院。查体：神志淡漠，面色苍白，四肢湿冷发凉，脉搏110次/分，血压85/65mmHg，腹部移动性浊音阳性，腹腔穿刺抽出不凝血液，留置导尿示尿量约20ml/h。在快速建立补液通路补充血容量的同时，对该病人首要的处理是

- A. 大量输注库存全血
- B. 继续观察，待补足晶体液后再评估
- C. 行全腹部CT明确脏器损伤细节
- D. 静脉滴注多巴胺维持血压
- E. 积极手术准备,实施紧急手术止血 

答案：E

解析：失血性休克的治疗主要包括补充血容量和积极处理原发病、控制出血两方面；对于脾破裂等急性活动性腹腔出血，需要在恢复血容量的同时积极进行手术准备，实施紧急手术止血。若病人对初始的充分补液反应较差，应考虑有活动性出血，尽快查明原因及时处理。参阅教材P154。

100. [B1型题 | 理解] batch031-M5-B1-001

模块：M5 | 页码：教材P154

低血容量性休克典型的血流动力学改变是

- A. CVP降低、心输出量下降、外周阻力增加 
- B. CVP增高、心输出量下降、外周阻力增加
- C. 心输出量增加、外周阻力降低、四肢温暖
- D. 中心静脉压降低、外周阻力降低
- E. 心输出量增加、中心静脉压增高

答案：A

解析：低血容量性休克的主要血流动力学改变：中心静脉压降低，回心血量减少，心输出量下降，外周血管阻力增加，心率加快；外周静脉塌陷，脉压变小。参阅教材P154。

101. [B1型题 | 理解] batch031-M5-B1-002

模块：M5 | 页码：教材P155

感染性休克中暖休克典型的血流动力学改变是

- A. CVP降低、心输出量下降、外周阻力增加
- B. CVP增高、心输出量下降、外周阻力增加

- C. 心输出量增加、外周阻力降低、四肢温暖 ✓
- D. 中心静脉压降低、外周阻力降低
- E. 心输出量增加、中心静脉压增高

答案：C

解析：暖休克多见于革兰氏阳性球菌感染，表现为意识清醒、皮肤潮红或粉红、不湿不凉、脉搏乏力慢但可触及、脉压 $>30\text{mmHg}$ 、毛细血管充盈时间 $<2\text{秒}$ 、尿量 $>30\text{ml/h}$ ，呈高动力状态（心输出量增加、外周阻力降低、四肢温暖）。参阅教材P155。

102. [X型题 | 应用] batch031-M5-X-001

模块：M5 | 页码：教材P155

感染性休克病人应在最初6小时内达到的复苏目标包括

- A. 尿量 $\geq 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ ✓
- B. 中心静脉或混合静脉血氧饱和度 $\geq 70\%$ ✓
- C. 中心静脉压达到 $8\sim 12\text{mmHg}$ ✓
- D. 平均动脉压 $\geq 65\text{mmHg}$ ✓
- E. 尿量 $\geq 100\text{ml/h}$

答案：ABCD

解析：教材规定感染性休克最初6小时复苏目标：①中心静脉压达到 $8\sim 12\text{mmHg}$ ；②平均动脉压 $\geq 65\text{mmHg}$ ；③尿量 $\geq 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ ；④中心静脉或混合静脉氧饱和度（ SvO_2 或 ScvO_2 ） $\geq 70\%$ 。故A、B、C、D正确；E错误，尿量目标为 $\geq 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 而非 $\geq 100\text{ml/h}$ 。对于低血压（平均动脉压 $<65\text{mmHg}$ ）或血乳酸 $\geq 4\text{mmol/L}$ 者，应按 30ml/kg 的标准进行液体复苏。参阅教材P155。

103. [X型题 | 理解] batch031-M5-X-002

模块：M5 | 页码：教材P150

休克失代偿期（休克期）的临床表现包括

- A. 神志淡漠,反应迟钝,意识模糊 ✓
- B. 脉搏细速、血压进行性下降 ✓
- C. 皮肤温暖干燥、颜面潮红
- D. 尿量减少甚至无尿 ✓
- E. 出冷汗、口唇肢端发绀、四肢厥冷 ✓

答案：ABDE

解析：A正确，失代偿期病人神情淡漠、反应迟钝，甚至意识模糊或昏迷；B正确，脉搏细速、血压进行性下降，严重时脉搏摸不清、血压测不出；C错误，皮肤温暖干燥、潮红为暖休克或休克代偿期表现为皮肤苍白，失代偿期出冷汗、口唇肢端发绀、四肢厥冷（E正确）；D正确，严重时少尿甚至无尿。若皮肤黏膜出现瘀斑或消化道出血提示已发展至DIC阶段。参阅教材P150。

104. [X型题 | 理解] batch031-M5-X-003

模块：M5 | 页码：教材P153

关于休克时血管活性药物的应用，正确的有

- A. 多巴胺是最常用的血管活性药，其药理作用与剂量有关 ✓
- B. 多巴酚丁胺对心肌的正性肌力作用较多巴胺强，能降低肺毛细血管楔压 ✓
- C. 去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克最理想的血管活性药物方案 ✓
- D. 间羟胺直接兴奋 α 、 β 受体，作用强于去甲肾上腺素
- E. 血压下降即应立即使用血管收缩药，无需先补足血容量

答案：ABC

解析：A正确，多巴胺兼具兴奋 α 、 β 1和多巴胺受体作用，其药理作用与剂量有关，抗休克时宜采取小剂量；B正确，多巴酚丁胺正性肌力作用较多巴胺强，能增加心输出量、降低肺毛细血管楔压；C正确；D错误，间羟胺系间接兴奋 α 、 β 受体，对心脏和血管的作用同去甲肾上腺素但作用弱，维持时间约30分钟；E错误，血管活性药物适用于经补足血容量后血压仍不稳定或休克症状未见缓解的严重休克。参阅教材P153。

M6（18题）

105. [A1型题 | 记忆] batch031-M6-A1-001

模块：M6 | 页码：教材P179

热射病病人典型的临床表现是

- A. 体温超过38°C，大汗淋漓
- B. 体温正常，腓肠肌对称性痉挛
- C. 体温超过40.5°C，高热、无汗、意识障碍 ✓
- D. 体温正常或略升高，面色苍白、皮肤湿冷
- E. 体温不超过38°C头晕乏力注意力不集中

答案：C

解析：热射病是中暑最严重的类型，表现为高热、无汗、意识障碍，体温超过40.5℃，可出现皮肤干燥灼热、谵妄、昏迷、抽搐、呼吸急促、心动过速等，严重者出现休克、心力衰竭、脑水肿、ARDS、DIC、MODS。A、E为先兆及轻症中暑表现，B为热痉挛，D为热衰竭。参阅教材P179。

106. [A1型题 | 理解] batch031-M6-A1-002

模块：M6 | 页码：教材P179

高温环境强体力作业的年轻人出现四肢及腹部肌肉阵发性痉挛，其主要原因是

- A. 高热引起脑细胞水肿
- B. 体内热量蓄积过多
- C. 外周血管扩张导致血压下降
- D. 大量出汗导致血液浓缩
- E. 出汗仅补水,致低钠低氯血症 ☒

答案：E

解析：热痉挛常发生于高温环境下强体力作业或运动的年轻人，出汗后水和盐分大量丢失，仅补充水或低张液，形成低钠血症、低氯血症，出现四肢、腹部、背部肌肉痉挛和疼痛，常发生于腓肠肌，呈对称性和阵发性，病人意识清楚，体温一般正常。参阅教材P179。

107. [A1型题 | 记忆] batch031-M6-A1-003

模块：M6 | 页码：教材P180

冻僵（意外低体温）是指机体中心体温低于

- A. 35°C ☒
- B. 36°C
- C. 36.5°C
- D. 37°C
- E. 37.5°C

答案：A

解析：冻僵又称意外低体温，是指处在寒冷环境中的机体中心体温低于35℃，伴神经和心血管系统损伤为主要表现的全身性疾病。参阅教材P180。

108. [A1型题 | 记忆] batch031-M6-A1-004

模块：M6 | 页码：教材P182

冻结性冻伤温水快速复温时，水温应控制在

- A. 32~35℃
- B. 37~39℃ ☒
- C. 40~42℃
- D. 43~45℃
- E. 45~50℃

答案：B

解析：温水快速复温水温应控制在37~39℃；水温超过39℃并不会使复温时间缩短，反而会使病人疼痛加剧，影响复温效果；水温超过42℃时会造成额外损伤。复温后注意保持冻伤部位干燥。参阅教材P182。

109. [A1型题 | 记忆] batch031-M6-A1-005

模块：M6 | 页码：教材P186

按中国九分法估算，成人双下肢（含双臀）面积占体表面积的

- A. 9%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 46% ☒
- E. 53%

答案：D

解析：中国九分法：头颈 $9 \times 1 = 9\%$ ，双上肢 $9 \times 2 = 18\%$ ，躯干 $9 \times 3 = 27\%$ ，双下肢 $9 \times 5 + 1 = 46\%$ 。参阅教材P186。[源:考研真题 GS-2003-079]

110. [A1型题 | 理解] batch031-M6-A1-006

模块：M6 | 页码：教材P186

浅Ⅱ度烧伤的创面特点是

- A. 粉红或红色，创面干燥，疼痛明显
- B. 白色、褐色，干燥似皮革，感觉消失

- C. 粉红、大水疱，创面潮湿，疼痛明显 ✓
- D. 粉红、出血性水疱，痛觉迟钝，常需植皮
- E. 创面蜡白、焦痂形成，痛觉消失

答案：C

解析：浅Ⅱ度伤及表皮生发层与真皮乳头层（真皮浅层），创面粉红、大水疱、潮湿、疼痛明显，10天～2周愈合，不留瘢痕，常有色素改变。A为Ⅰ度，B、E为Ⅲ度，D为深Ⅱ度。参阅教材P186。[源:考研真题 GS-2014-041]

111. [A1型题 | 记忆] batch031-M6-A1-007

模块：M6 | 页码：教材P187

电流作用下，人体各组织对电流的阻力按自小而大的顺序排列，正确的是

- A. 皮肤肌肉血管神经脂肪肌腱骨组织
- B. 血管神经肌肉皮肤脂肪肌腱骨组织 ✓
- C. 骨组织肌腱脂肪皮肤肌肉神经血管
- D. 神经血管肌肉脂肪皮肤骨组织肌腱
- E. 肌肉血管神经皮肤肌腱脂肪骨组织

答案：B

解析：身体各组织单独对电流的阻力按自小而大顺序依次为血管、神经、肌肉、皮肤、脂肪、肌腱、骨组织；电流通过心脏易导致心脏骤停，通过脑干则导致中枢神经麻痹、呼吸暂停。参阅教材P187。

112. [A1型题 | 理解] batch031-M6-A1-008

模块：M6 | 页码：教材P177

溺水3～4分钟获救，神志丧失，无脉搏血压，面色苍白肿胀。按淹溺程度分类，该患者属于

- A. 轻度淹溺：意识清楚，血压升高
- B. 中度淹溺：剧烈呛咳，意识模糊
- C. 重度淹溺：昏迷，四肢厥冷，口鼻血性泡沫 ✓
- D. 迟发性淹溺：初期症状轻，后出现肺水肿
- E. 浸渍综合征：低温液体致心律失常、晕厥

答案：C

解析：按临床表现将淹溺分为轻、中、重三度：轻度——落水片刻，吸入或吞入少量液体，反射性呼吸暂停，意识清楚，血压升高，心率加快；中度——溺水1~2分钟，水经呼吸道或消化道进入，剧烈呛咳、呕吐，意识模糊、烦躁，呼吸不规则或表浅，血压下降，心率减慢，反射减弱；重度——溺水3~4分钟，昏迷，面色发绀或苍白肿胀，眼球突出，四肢厥冷，血压测不到，口鼻血性泡沫，胃扩张、上腹膨隆，可有抽搐，呼吸心搏微弱或停止。本例溺水3~4分钟、神志丧失、无脉搏血压、面色苍白肿胀，符合重度淹溺。D迟发性淹溺指溺水后初期症状较轻，数小时至1天后出现肺水肿等表现；E浸渍综合征指较长时间浸于低温液体（中心体温低于35℃），出现心律失常、晕厥等表现。教材P177。

113. [A2型题 | 应用] batch031-M6-A2-001

模块：M6 | 页码：教材P179

男性，22岁，烈日下军事训练2小时后昏迷倒地。查体：体温41℃，皮肤灼热干燥无汗，呼吸急促。现场首要的急救措施是

- A. 立即口服含盐清凉饮料
- B. 立即静脉滴注氯丙嗪25~50mg
- C. 立即行气管插管、机械通气
- D. 脱离高温环境，用冷水浸泡快速降温 ☒
- E. 静脉滴注甘露醇脱水降颅压

答案：D

解析：热射病快速降温是治疗的首要措施，病死率与体温过高及持续时间密切相关，如果降温延迟，病死率明显增高；当病人脱离高温环境后应立即开始降温，可采用冷水浸泡、喷洒凉水并持续扇风蒸发、冰毯冰袋等体外降温方法。参阅教材P179。

114. [A2型题 | 应用] batch031-M6-A2-002

模块：M6 | 页码：教材P178

男性，18岁，淡水淹溺经抢救恢复自主呼吸。查体：血钠126mmol/L，尿呈酱油色，血红蛋白进行性下降。其液体管理原则是

- A. 及时补充液体，严格控制氯化钠溶液入量
- B. 限制入水量，补充氯化钠溶液、血浆和白蛋白 ☒
- C. 大量输注5%葡萄糖溶液稀释血液
- D. 大量补充高渗盐水快速纠正低钠血症
- E. 快速静脉输注右旋糖酐40扩容蛋白

答案：B

解析：淡水淹溺时因血液稀释，应适当限制入水量，并适当补充氯化钠溶液、血浆和白蛋白；海水淹溺时大量体液渗入肺组织、血容量偏低，需及时补充液体，严格控制氯化钠溶液的入量（A为海水淹溺原则）。注意纠正高钾血症及酸中毒，对发生溶血者及时碱化尿液。参阅教材P178。

115. [A2型题 | 应用] batch031-M6-A2-003

模块：M6 | 页码：教材P188

工人在检修电路时触电倒地，身体仍与电线接触。现场施救者首先应

- A. 徒手将触电者拉开
- B. 立即行心肺复苏
- C. 立即拨打急救电话等待专业人员
- D. 立即检查触电者意识和呼吸
- E. 切断电源,使触电者脱离电源 ☒

答案：E

解析：电击伤现场急救首先强调确保现场救助者自身的安全，在第一时间切断电源，或用绝缘物使触电者与电源分离，或采取保护措施将伤者搬离危险区；对心脏、呼吸骤停者再立即行心肺复苏。参阅教材P188。

116. [A2型题 | 分析] batch031-M6-A2-004

模块：M6 | 页码：教材P186

男性，30岁，火焰烧伤双上肢及躯干，全部创面均出现大水疱、剧痛。按中国九分法估算，其烧伤总面积和伤情分类为

- A. 27%，中度烧伤
- B. 36%，中度烧伤
- C. 45%，重度烧伤 ☒
- D. 45%，特重度烧伤
- E. 54%，特重度烧伤

答案：C

解析：双上肢18%+躯干27%=45%；创面大水疱、剧痛为浅Ⅱ度烧伤。烧伤总面积达30%~49%为重度烧伤（或Ⅲ度烧伤面积在10%~19%）；特重度烧伤指烧伤面积50%及以上或Ⅲ度烧伤面积在20%及以上。故本例为45%、重度烧伤。参阅教材P186。

117. [A3型题 | 应用] batch031-M6-A3-001

模块：M6 | 页码：教材P179

男性，25岁，盛夏高温环境下长途负重行军后意识不清30分钟。查体：体温41.2℃，皮肤灼热、干燥无汗，呼吸30次/分，心率140次/分，血压100/60mmHg，双肺未闻及啰音，病理征阴性。最可能的诊断是

- A. 劳力性热射病 ☒
- B. 非劳力性热射病
- C. 中暑热衰竭
- D. 中暑热痉挛
- E. 急性脑血管意外

答案：A

解析：在高温、高湿或强烈太阳照射环境中作业或运动数小时后发病者为劳力性热射病，表现为高热、无汗、意识障碍，体温超过40.5℃；本例青年、强体力行军后发病，符合劳力性热射病。经典型多见于老年、体弱、有慢性病病人在高温和通风不良环境中维持数日。热衰竭意识障碍不明显，热痉挛意识清楚、体温一般正常。参阅教材P179。

118. [A3型题 | 应用] batch031-M6-A3-002

模块：M6 | 页码：教材P179

男性，25岁，盛夏高温环境下长途负重行军后意识不清30分钟。查体：体温41.2℃，皮肤灼热、干燥无汗，呼吸30次/分，心率140次/分，血压100/60mmHg，双肺未闻及啰音，病理征阴性。对该病人进行降温，正确的目标是

- A. 2小时内降至39℃以下即可
- B. 4小时内缓慢降至38.5℃以下
- C. 10分钟内降至36℃以下
- D. 40分钟内至39℃,2小时内至38.5℃ ☒
- E. 60分钟内降至37℃以下

答案：D

解析：热射病降温目标：核心体温在10~40分钟内迅速降至39℃以下，2小时内降至38.5℃以下，达到正常体温时停止降温，避免体温过低。体外降温可用冷水浸泡（降温速度可达0.2℃/min）、蒸发降温、冰毯冰袋等；体内降温可用4℃盐水200ml灌胃或直肠灌洗等。参阅教材P179。

119. [B1型题 | 理解] batch031-M6-B1-001

模块：M6 | 页码：教材P188

闪电击伤病人查体时最典型的皮肤体征是

- A. 局部有横行排列的两个点状牙痕
- B. 口腔及鼻腔充满血性泡沫
- C. 共济失调伴剧烈头痛、恶心呕吐
- D. 复温皮肤呈红色或紫红色,充血水肿,无水疱
- E. 皮肤出现微红的树枝样或细条状条纹 ☒

答案：E

解析：闪电损伤时皮肤上可出现微红的树枝样或细条状条纹，这是电流沿着或穿过皮肤所致的Ⅰ度或Ⅱ度烧伤；佩戴指环、手表、项链或腰带处可有较深的烧伤。A为蜈蚣咬伤的牙痕特点，B为重度淹溺的表现，C为高原脑水肿的最早特异性症状，D为Ⅰ度冻伤复温后表现。参阅教材P188。

120. [B1型题 | 理解] batch031-M6-B1-002

模块：M6 | 页码：教材P181

Ⅰ度（红斑性）冻伤复温后的表现是

- A. 局部有横行排列的两个点状牙痕
- B. 口腔及鼻腔充满血性泡沫复温
- C. 共济失调伴剧烈头痛、复温后恶心呕吐
- D. 复温皮肤呈红色或紫红色,充血水肿,无水疱 ☒
- E. 皮肤出现微红的树枝样或细条状条纹

答案：D

解析：Ⅰ度冻伤为红斑性冻伤，损害在表层，受冻皮肤早期苍白，复温后呈红色或紫红色，充血水肿，无水疱，1周后脱屑愈合，不留瘢痕。Ⅱ度冻伤为水疱性冻伤，Ⅲ度、Ⅳ度为坏死性及深层坏死。参阅教材P181。

121. [X型题 | 应用] batch031-M6-X-001

模块：M6 | 页码：教材P179

关于热射病的治疗，正确的有

- A. 快速降温是治疗的首要措施，病死率与体温过高及持续时间密切相关 ✓
- B. 核心体温应在10~40分钟内降至39℃以下，2小时内降至38.5℃以下 ✓
- C. 液体复苏首选含钠液体，第一个小时输液总量可达1.5~2L ✓
- D. 应早期大量输注葡萄糖注射液以快速补充能量
- E. 氯丙嗪25~50mg加入液体内静脉滴注，同时严密监测血压 ✓

答案：ABCE

解析：A正确，快速降温是治疗的首要措施，降温延迟病死率明显增高；B正确，降温目标为核心体温在10~40分钟内降至39℃以下、2小时内降至38.5℃以下，达到正常体温时停止降温；C正确，液体复苏首选含钠液体如生理盐水或林格液，输液速度以维持尿量100~200ml/h为准，第一个小时输液总量可达1.5~2L；D错误，应避免早期大量输注葡萄糖注射液，以免血钠在短时间内快速下降、加重神经损伤；E正确，氯丙嗪25~50mg加入250~500ml液体内静脉滴注1~2小时，需严密监测血压。参阅教材P179、P180。

122. [X型题 | 理解] batch031-M6-X-002

模块：M6 | 页码：教材P182

关于冻结性冻伤的急救处理，正确的有

- A. 迅速脱离寒冷环境，保暖并尽早快速复温 ✓
- B. 温水快速复温，水温控制在37~39℃ ✓
- C. 严禁火烤雪搓，冷水浸泡或猛力捶打冻伤部位 ✓
- D. 可静脉滴注右旋糖酐40以降低血液黏稠度、改善微循环 ✓
- E. 复温越快越好，可用45℃以上热水浸泡以缩短复温时间

答案：ABCD

解析：A正确，治疗原则包括迅速脱离寒冷环境、保暖、尽早快速复温；B正确，温水快速复温水温应控制在37~39℃；C正确，严禁火烤、雪搓、冷水浸泡或猛力捶打冻伤部位；D正确，右旋糖酐40静脉滴注每日500~1 000ml，维持7~14天，以降低血液黏稠度、改善微循环；E错误，水温超过39℃并不会使复温时间缩短，反而会使疼痛加剧，超过42℃会造成额外损伤。参阅教材P182。

M7 (18题)

123. [A1型题 | 记忆] batch035-M7-A1-001

模块：M7 | 页码：教材P209

多器官功能障碍综合征（MODS）是指机体在多种急性致病因素所致原发病变的基础上，相继引发2个或2个以上器官同时或序贯出现的功能障碍，其功能障碍的性质是

- A. 不可逆性功能障碍
- **B. 可逆性功能障碍** ✓
- C. 进行性加重的功能障碍
- D. 永久性功能障碍
- E. 静止性功能障碍

答案：B

解析：MODS是指在多种急性致病因素所致机体原发病变的基础上，相继引发2个或2个以上器官同时或序贯出现的可逆性功能障碍的临床综合征。MODS强调的是器官功能障碍是一个连续的、动态的演变过程，治愈后器官功能可望恢复到病前状态。教材P209。

124. [A1型题 | 理解] batch035-M7-A1-002

模块：M7 | 页码：教材P209

关于多器官功能障碍综合征（MODS）与多器官功能衰竭（MOF）的关系，下列描述正确的是

- A. MODS与MOF是两个不同的疾病
- **B. MOF是MODS的终末阶段** ✓
- C. MODS是MOF的终末阶段
- D. MODS与MOF是同一概念的不同表述
- E. MOF不可逆，MODS可逆

答案：B

解析：MODS的提出是对MOF认识上的深化，MOF是MODS的终末阶段。MODS的器官功能障碍可以是相对的，也可以是绝对的，强调的是器官功能障碍是一个连续的、动态的演变过程，MOF是MODS的终末阶段。教材P209。

125. [A1型题 | 记忆] batch035-M7-A1-003

模块：M7 | 页码：教材P209

1992年，美国胸科医师协会（ACCP）/美国重症医学会（SCCM）正式提出MODS的概念，在此之前，1973年首次提出"序贯性系统衰竭"概念的学者是

- **A. Tilney** ✓

- B. Eiseman
- C. Fry（弗雷）
- D. Marshall
- E. Sauaia

答案：A

解析：1973年Tilney首次提出了"序贯性系统衰竭"的概念，并指出继发功能障碍的器官可以是远隔器官。1977年Eiseman将不同原发疾病导致的多个器官相继发生功能衰竭命名为"多器官功能衰竭"。教材P209。

126. [A1型题 | 理解] batch035-M7-A1-004

模块：M7 | 页码：教材P210

目前认为MODS最重要的病理生理基础是

- A. 组织缺血再灌注损伤
- B. 肠道屏障功能破坏
- **C. 二次打击所致炎症反应失控** ✓
- D. 细菌毒素直接损害
- E. 基因调控异常

答案：C

解析：炎症反应被认为是MODS发病的基石，组织缺血-再灌注和/或全身炎症反应是其共同的病理生理基础，二次打击所致的炎症反应失控被认为是MODS最重要的病理生理基础。教材P210。

127. [A1型题 | 理解] batch035-M7-A1-005

模块：M7 | 页码：教材P211

代偿性抗炎反应综合征（CARS）的病理生理特点是

- A. 促炎症介质过度释放，抗炎症介质不足
- **B. 抗炎症介质过度释放，免疫功能抑制** ✓
- C. 促炎与抗炎介质均过度释放
- D. 促炎与抗炎介质均释放不足
- E. 炎症介质释放正常，靶细胞反应性降低

答案：B

解析：代偿性抗炎症介质过度释放，促炎症介质/抗炎症介质平衡失调，导致免疫抑制状态，称为CARS。其特点是IL-4、IL-10、IL-11、IL-13等抗炎症介质释放过多，单核巨噬细胞活性下降，抗原呈递功能减弱，T细胞反应低下，造成"免疫麻痹"。教材P211。

128. [A1型题 | 理解] batch035-M7-A1-006

模块：M7 | 页码：教材P212

MODS的临床特点不包括下列哪项

- A. 从原发损伤到器官功能障碍有时间间隔
- B. 功能障碍的器官多是受损器官的远隔器官
- C. 循环系统处于"高排低阻"的高动力状态
- D. 持续性高代谢状态和能源利用障碍
- E. 循环系统处于"低排高阻"的低动力状态 

答案：E

解析：MODS的临床特点包括：①从原发损伤到发生器官功能障碍有一定的时间间隔；②功能障碍的器官多是受损器官的远隔器官；③循环系统处于"高排低阻"的高动力状态；④持续性高代谢状态和能源利用障碍；⑤氧利用障碍。"低排高阻"是心源性休克等早期的表现，不是MODS的特点。教材P212。

129. [A1型题 | 记忆] batch035-M7-A1-007

模块：M7 | 页码：教材P212

原发性MODS与继发性MODS的主要区别在于

- A. 发病是否与感染有关
- B. 发病是否与创伤有关
- C. SIRS是否起主导作用 
- D. 是否累及远隔器官
- E. 是否伴有循环功能障碍

答案：C

解析：原发性MODS是严重创伤、大量多次输血等明确的生理打击直接作用的结果，SIRS未起主导作用；继发性MODS并非损伤的直接后果，而是机体异常反应的结果，原发损伤引起SIRS，进一步导致自身破坏，造成远隔器官功能障碍。教材P212。

130. [A1型题 | 记忆] batch035-M7-A1-008

模块：M7 | 页码：教材P213

关于MODS修正的Fry诊断标准，循环系统功能障碍的诊断标准是收缩压低于90mmHg持续多长时间以上

- A. 持续1小时以上 ☒
- B. 持续2小时以上
- C. 持续4小时以上
- D. 持续15分钟以上
- E. 持续30分钟以上

答案：A

解析：修正的Fry诊断标准中循环系统标准：收缩压<90mmHg，持续1小时以上，或循环需要药物支持才能维持稳定。呼吸系统标准：氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) ≤ 200 mmHg。肾脏标准：血肌酐浓度 $>177\mu\text{mol/L}$ 。教材P213。

131. [A2型题 | 应用] batch035-M7-A2-001

模块：M7 | 页码：教材P213

男性，55岁，因重症胰腺炎入院。入院后第3天出现呼吸急促、低氧血症， $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 为180mmHg，胸部X线片见双肺浸润。第5天出现少尿、血肌酐升高至 $200\mu\text{mol/L}$ 。第7天出现上消化道出血，24小时出血量约500ml。该患者目前最可能的诊断是

- A. 急性呼吸窘迫综合征
- B. 急性肾损伤
- C. 应激性溃疡
- D. 多器官功能障碍综合征 ☒
- E. 全身炎症反应综合征

答案：D

解析：患者有重症胰腺炎诱因，相继出现呼吸功能（氧合指数 ≤ 200 mmHg）、肾功能（血肌酐 $>177\mu\text{mol/L}$ ）、胃肠道（上消化道出血24h >400 ml）三个器官序贯功能障碍，符合MODS诊断标准。SIRS是全身性炎症反应，MODS是多个器官功能障碍。教材P213。

132. [A2型题 | 应用] batch035-M7-A2-002

模块：M7 | 页码：教材P214

男性，68岁，因肺部感染入院。查体：T 38.9℃，P 112次/分，R 26次/分，BP 96/60mmHg。意识模糊，呼吸急促。实验室检查：WBC $15.2 \times 10^9/L$ ，血乳酸3.5mmol/L。qSOFA评分：呼吸频率 ≥ 22 次/分（1分），意识改变（1分），收缩压 ≤ 100 mmHg（1分），共计3分。该患者最可能的诊断是

- A. 单纯肺部感染
- B. 全身炎症反应综合征
- C. 急性脓毒症 ☒
- D. 感染性休克
- E. 多器官功能障碍

答案：C

解析：有感染证据（肺部感染），qSOFA评分 ≥ 2 分（本例3分），可诊断为脓毒症。感染性休克诊断需满足：充分液体复苏后仍需升压药维持MAP ≥ 65 mmHg且血乳酸 > 2 mmol/L。本例尚无充分液体复苏后仍需升压药的证据，诊断为脓毒症更为准确。教材P214。

133. [A2型题 | 应用] batch035-M7-A2-003

模块：M7 | 页码：教材P213-214

男性，60岁，严重创伤后出现多器官功能障碍。查体：GCS评分10分，实验室检查：PaO₂/FiO₂ 160mmHg，血清肌酐280μmol/L，血胆红素85μmol/L，血小板计数 $60 \times 10^9/L$ ，PAR（压力调整后心率）为18次/分。根据Marshall多器官功能障碍综合征计分系统，该患者呼吸系统、肾脏、肝脏、血液系统、心血管系统和中枢神经系统的总分值约为

- A. 8~9分
- B. 10~11分
- C. 12~13分 ☒
- D. 14~15分
- E. 16~17分

答案：C

解析：Marshall计分：呼吸系统（PaO₂/FiO₂ 151~225为2分），肾脏（肌酐201~350为2分），肝脏（胆红素61~120为2分），血液系统（血小板51~80为2分），心血管系统（PAR 15.1~20.0为2分），中枢神经系统（GCS 10~12为2分），总分约12分。MODS计分分数与病死率呈显著正相关。教材P213-214。

134. [A2型题 | 应用] batch035-M7-A2-004

模块：M7 | 页码：教材P215

男性，45岁，因化脓性胆管炎致脓毒症、感染性休克。经充分液体复苏后，血压仍依赖去甲肾上腺素维持，血乳酸3.8mmol/L。关于该患者的治疗措施，下列哪项是正确的

- A. 首选多巴胺作为血管升压药(降血压)
- B. 首选去甲肾上腺素纠正低血压 ☒
- C. 常规大剂量使用糖皮质激素
- D. 抗生素疗程固定为14天去甲肾上腺素
- E. 早期给予高容量机械通气

答案：B

解析：脓毒症伴低血压者首选去甲肾上腺素或多巴胺作为血管升压药物，但去甲肾上腺素是首选推荐。激素仅对液体复苏和血管升压药治疗不敏感者考虑小剂量短疗程应用。抗生素推荐疗程一般为7~10天。机械通气应采用小潮气量肺保护策略。教材P215。

135. [A3型题 | 应用] batch035-M7-A3-001

模块：M7 | 页码：教材P212

男性，50岁，因严重多发伤入院。入院后第1天出现烦躁，轻度呼吸性碱中毒，少尿但利尿剂有效，血小板轻度减少。根据MODS临床分期，该患者目前处于哪一期

- A. 1期 ☒
- B. 2期
- C. 3期
- D. 4期
- E. 无法分期

答案：A

解析：MODS 1期临床表现：一般情况正常或轻度烦躁；循环系统需补充容量；呼吸系统轻度呼吸性碱中毒；肾脏少尿、利尿剂有效；胃肠道胀气；肝脏正常或轻度胆汁淤积；血液系统正常或轻度异常。该患者符合1期表现。教材P212。

136. [A3型题 | 分析] batch035-M7-A3-002

模块：M7 | 页码：教材P215-216

男性，50岁，因严重多发伤入院。入院后第1天出现烦躁，轻度呼吸性碱中毒，少尿但利尿剂有效，血小板轻度减少。该患者目前最重要的治疗原则是

- A. 立即开始大剂量激素冲击治疗

- B. 积极控制原发病并加强器官功能监测 ☒
- C. 立即开始持续肾脏替代治疗
- D. 立即开始机械通气治疗
- E. 立即开始抗凝治疗

答案：B

解析：MODS 1期为早期阶段，此时器官功能障碍尚可逆。治疗重点在于早期识别、积极控制原发病（如感染、创伤等），严密监测各器官功能变化，及时干预，阻断单一受累脏器向多脏器发展的病理生理过程。对高危病人进行严密监测，能早诊断、早治疗，降低病死率。教材P215-216。

137. [B1型题 | 记忆] batch035-M7-B1-001

模块：M7 | 页码：教材P210

MODS发病机制中，强调机体遭受初次损伤后，经过一段时间再次出现损伤性刺激，炎症反应被放大而导致器官功能障碍的学说称为

- A. 缺血再灌注损伤学说
- B. 炎症反应失控学说
- C. 肠道屏障功能破坏学说
- D. 二次打击或双相预激学说 ☒
- E. 基因调控学说

答案：D

解析：二次打击或双相预激学说强调机体遭受初次打击后，炎症反应被预激（priming），再次受到打击后炎症反应被放大，导致器官功能障碍。各种学说从不同侧面阐明了MODS的发病机制，相互之间有一定重叠和联系。教材P210。

138. [B1型题 | 理解] batch035-M7-B1-002

模块：M7 | 页码：教材P210

MODS发病机制中被认为是发病基石，使治疗从控制感染延伸到调控机体炎症反应的学说是

- A. 组织缺血再灌注损伤学说
- B. 炎症反应失控学说 ☒
- C. 肠道屏障功能破坏学说
- D. 二次打击或双相预激学说
- E. 基因调控学说炎症反应

答案：B

解析：炎症反应学说被认为是MODS发病的基石。SIRS的提出使对MODS的研究从感染、创伤等本身转移到机体炎症反应方面上来，也使MODS的治疗从控制感染、创伤延伸到调控机体炎症上。教材P210。

139. [X型题 | 理解] batch035-M7-X-001

模块：M7 | 页码：教材P210

下列哪些是诱发MODS的主要高危因素

- A. 年龄≥55岁 ✓
- B. 创伤严重度评分≥25分 ✓
- C. 大量反复输血 ✓
- D. 持续存在感染病灶 ✓
- E. 长期营养不良 ✓

答案：ABCDE

解析：诱发MODS的主要高危因素包括：复苏不充分或延迟复苏、营养不良、持续存在感染病灶、肠道缺血性损伤、持续存在炎症病灶、外科手术、基础脏器功能障碍、糖尿病、年龄≥55岁、应用糖皮质激素、嗜酒、恶性肿瘤、大量反复输血、使用抑酸药物、创伤严重度评分≥25分、高乳酸血症等。教材P210。[源:考研真题 GS-1999-158]

140. [X型题 | 理解] batch035-M7-X-002

模块：M7 | 页码：教材P215-216

关于脓毒症的急诊处理，正确的措施有

- A. 对严重脓毒症伴组织低灌注者应早期实施液体复苏 ✓
- B. 首选去甲肾上腺素纠正感染性休克低血压 ✓
- C. 对所有脓毒症病人常规大剂量使用糖皮质激素
- D. 脓毒症所致ARDS应尽早行小潮气量肺保护性通气 ✓
- E. 推荐抗生素疗程一般为7~10天 ✓

答案：ABDE

解析：A对：严重全身性感染伴组织低灌注者应立即实施早期复苏。B对：首选去甲肾上腺素或多巴胺作为纠正感染性休克低血压的血管升压药物。C错：仅对液体复苏和血管升压药治疗不敏感者考虑小剂量短疗程应用激素，不常规大剂量使用。D对：脓毒症所致

ALI/ARDS病人应尽早机械通气，实行小潮气量、适当PEEP的肺保护性通气策略。E对：推荐抗生素疗程一般为7~10天。教材P215-216。

M8 (28题)

141. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-001

模块：M8 | 页码：教材P232

心脏骤停的"三联征"是指

- A. 意识丧失、呼吸停止、血压测不出
- **B. 意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失** ✓
- C. 意识丧失、心音消失、双侧瞳孔散大
- D. 呼吸停止、心音消失、大动脉搏动消失
- E. 意识丧失、双侧瞳孔散大、心音消失

答案：B

解析：心脏骤停"三联征"为突发意识丧失、呼吸停止和大动脉搏动消失。临床表现为：突然摔倒，意识丧失；呼吸停止或叹息样呼吸；大动脉搏动消失，触摸不到颈、股动脉搏动，心音消失；双侧瞳孔散大，对光反射消失。教材P232。

142. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-002

模块：M8 | 页码：教材P232

下列哪项不是心脏骤停的心电图表现类型

- A. 心室颤动
- B. 无脉性室速
- C. 心室静止
- D. 无脉性电活动
- **E. 心房颤动** ✓

答案：E

解析：心脏骤停的心电图表现包括：心室颤动（VF）、无脉性室性心动过速、心室静止（VA）、无脉性电活动（PEA）。心房颤动不是心脏骤停的心电图表现，心房颤动时心脏仍有射血功能。教材P232。

143. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-003

模块：M8 | 页码：教材P231-232

正常体温情况下，心脏骤停后脑细胞开始发生不可逆缺血损害的时间是

- A. 2分钟后
- B. 4分钟后 ✓
- C. 6分钟后
- D. 8分钟后
- E. 10分钟后

答案：B

解析：大脑是人体最易受缺血缺氧损害的器官。正常体温情况下，心脏骤停4分钟后，脑细胞开始发生不可逆的缺血损害；心脏骤停10分钟内未行心肺复苏，神经功能极少能恢复到发病前的水平。教材P231-232。

144. [A1型题 | 理解] batch035-M8-A1-004

模块：M8 | 页码：教材P232

关于胸外按压的机制，将血液驱向体循环和肺循环的主要理论是

- A. 心泵理论 ✓
- B. 胸泵理论
- C. 腹泵理论
- D. 肺泵理论
- E. 主动脉泵理论

答案：A

解析：心泵理论认为胸外按压时心脏受到胸骨和胸椎的挤压，心室和大动脉之间产生压力梯度，驱使血液流向体循环和肺循环。胸泵理论认为胸外按压时胸腔内压力增高，在胸腔内血管和胸腔外血管之间形成压力梯度。教材P232。

145. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-005

模块：M8 | 页码：教材P235

高质量胸外按压的按压频率和按压幅度标准是

- A. 频率80~100次/分，幅度4~5cm

- B. 频率80~100次/分，幅度5~6cm
- **C. 频率100~120次/分，幅度5~6cm** ✓
- D. 频率100~120次/分，幅度4~5cm
- E. 频率120~140次/分，幅度5~6cm

答案：C

解析：高质量胸外按压标准：按压频率为100~120次/分；按压幅度为5~6cm；确保按压后放松期胸廓完全恢复原状；尽量减少胸外按压中断，中断时间<10秒。按压与放松时间相等，放松时手掌不离开胸壁。教材P235。

146. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-006

模块：M8 | 页码：教材P235

成人单人心肺复苏时，胸外按压与人工通气的比例是

- A. 5:1
- B. 15:2
- C. 15:1
- **D. 30:2** ✓
- E. 30:1

答案：D

解析：成人无论单人还是双人CPR，按压与通气比均为30:2。每5组30:2的CPR为一个周期，时间约2分钟。2人以上CPR时应每隔2分钟轮换一次，以免按压者疲劳使按压质量和频率降低。教材P235。

147. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-007

模块：M8 | 页码：教材P236

对怀疑有颈椎损伤的心脏骤停患者，开放气道时应采用的方法是

- A. 仰头抬颏法
- **B. 双手托颌法** ✓
- C. 仰头举颏法
- D. 气管插管法
- E. 口咽通气管法

答案：B

解析：双手托颌法用于怀疑病人有颈椎受伤时。病人平卧，急救者位于病人头侧，双手拇指置于病人口角旁，其余手指托住病人下颌部位，在保证头部和颈部固定的前提下，用力将病人下颌向上抬起。仰头抬颏法用于无明显头颈部受伤者。教材P236。

148. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-008

模块：M8 | 页码：教材P237

成人电除颤时，双相波除颤的首次能量选择是

- A. 50~100J
- B. 120~200J ☒
- C. 200~300J
- D. 300~360J
- E. 360J

答案：B

解析：双相波除颤能量选择为120~200J，随后的除颤能量选择可使用第一次的能量或增加能量。单相波除颤使用360J。电击除颤是终止心室颤动的最有效方法，早期电击除颤是决定心脏骤停病人能否存活的关键因素。教材P237。

149. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-009

模块：M8 | 页码：教材P242

心肺复苏中，成人首选的血管升压药物及其推荐剂量是

- A. 肾上腺素1mg，每隔3~5分钟可重复 ☒
- B. 去甲肾上腺素1mg，每隔5分钟可重复
- C. 肾上腺素2mg，每隔5分钟可重复
- D. 多巴胺5mg，每隔3~5分钟可重复
- E. 多巴酚丁胺5mg，每隔3~5分钟可重复

答案：A

解析：肾上腺素在复苏过程中的作用主要是激动 α 受体，提高复苏过程中心脏和脑的灌注压。推荐成人首选给予肾上腺素1mg，每隔3~5分钟可重复使用。对CPR、电除颤和血管升压药物无反应的VF/VT，首选胺碘酮。教材P242。[源:考研真题 GS-1994-090]

150. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-010

心肺复苏中，对CPR、电除颤和血管升压药物无反应的室颤/无脉性室速（VF/VT），首选的抗心律失常药物及其初始剂量是

- A. 利多卡因1.5mg/kg静脉注射
- B. 硫酸镁2g静脉注射
- C. 利多卡因100mg静脉注射
- D. 胺碘酮150mg静脉注射
- E. 胺碘酮300mg静脉注射 ☒

答案：E

解析：对CPR、电除颤和血管升压药物无反应的VF/VT，首选胺碘酮，初始剂量为300mg（或5mg/kg），静脉注射，无效时可再加用150mg。利多卡因作为无胺碘酮时的替代药物。镁剂用于尖端扭转型室性心动过速。教材P242。

151. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-011

心肺复苏中，反映心输出量的可靠指标是

- A. 动脉收缩压(SBP)
- B. 呼气末CO₂分压(PetCO₂) ☒
- C. 中心静脉压(CVP)
- D. 肺动脉楔压(PAWP)
- E. 血乳酸水平(Lac)

答案：B

解析：呼气末CO₂分压（PetCO₂）可作为心肺复苏中反映心输出量的可靠指标。PetCO₂与冠状动脉灌注压（CPP）、脑灌注压变化呈正相关。在未使用血管活性药物的情况下，PetCO₂<10mmHg提示预后不良。CPP>15mmHg是复苏成功的必需条件。教材P234。

152. [A1型题 | 记忆] batch035-M8-A1-012

ILCOR推荐的院外心脏骤停意识丧失成人低温治疗的目标温度和持续时间是

- A. 30~32℃，持续6~12小时
- B. 30~32℃，持续24~48小时

- C. 32~34°C, 持续12~24小时 ✓
- D. 32~34°C, 持续24~48小时
- E. 34~36°C, 持续12~24小时

答案: C

解析: ILCOR于2003年提出: 院外心脏骤停和初始心律为室颤的意识丧失成人, 应予32~34°C的低温治疗12~24小时。对其他初始心律和院内心脏骤停的病人, 此治疗同样有益。低温治疗已被证实是有效的脑保护措施。教材P247。

153. [A1型题 | 理解] batch035-M8-A1-013

模块: M8 | 页码: 教材P232-233

心脏骤停后综合征 (PCAS) 被定义为严重的全身系统性缺血后出现的

- A. 单一器官功能障碍
- B. 多器官功能障碍和衰竭 ✓
- C. 单纯脑功能障碍
- D. 单纯心肌功能障碍
- E. 呼吸功能衰竭

答案: B

解析: 心脏骤停后综合征 (PCAS) 被定义为严重的全身系统性缺血后多器官功能障碍和衰竭。复苏后期的病理生理特征为持续缺血诱发的代谢紊乱及再灌注启动的系列级联反应, 两者都介导了细胞的继发性损伤。包括心脏骤停后脑损害、心肌损害、全身性缺血/再灌注损伤等。教材P232-233。

154. [A2型题 | 应用] batch035-M8-A2-001

模块: M8 | 页码: 教材P235

男性, 60岁, 冠心病病史。在餐厅就餐时突然倒地, 呼之不应。你作为现场第一目击者, 应首先采取的措施是

- A. 拨打急救电话等待专业救援
- B. 判断无反应启动EMSS开始CPR ✓
- C. 立即行气管插管通气
- D. 立即实施电除颤治疗
- E. 立即将患者送往医院

答案：B

解析：发现突然意识丧失倒地者，现场人员首先要确定现场安全，采用动作或呼叫判断病人有无意识。无反应病人应采取平卧位，立即启动EMSS，检查呼吸和脉搏（5~10秒），确认无呼吸或仅有异常呼吸且不能明确触及大动脉搏动时，立即开始CPR。教材P235。

155. [A2型题 | 应用] batch035-M8-A2-002

模块：M8 | 页码：教材P237

男性，55岁，院外发生心脏骤停，未被目击。急救人员到达现场时距离呼救已有较长时间。此时应首先采取的急救措施是

- A. 立即实施电除颤治疗
- **B. 先做5组CPR约2分钟再分析心律** ✓
- C. 立即行气管插管通气
- D. 立即静脉注射肾上腺素
- E. 立即建立静脉通道

答案：B

解析：当院外心脏骤停发生时未被急救人员目击，尤其是从呼救至急救人员到达现场的时间超过5分钟的情况下，先进行30次胸外按压，再做2次人工呼吸，行5组CPR（约2分钟），分析心律后实施电除颤。对心室颤动时间>4分钟的病人，电击前的胸外按压尤为重要。教材P237。

156. [A2型题 | 应用] batch035-M8-A2-003

模块：M8 | 页码：教材P239

男性，70岁，进食肉类时突然出现剧烈呛咳，随后不能说话，呼吸困难，双手抓住颈部，面色发绀。此时最紧急的处理措施是

- A. 立即行气管切开术
- **B. 腹部冲击法(Heimlich)** ✓
- C. 立即行气管插管术
- D. 立即给予高流量吸氧
- E. 立即行胸部冲击法

答案：B

解析：患者典型气道完全阻塞表现（不能说话、呼吸困难、双手抓住颈部、发绀），应立即行腹部冲击法（Heimlich法）解除气道异物。救助者站在病人身后，双臂环抱病人腰部，一

手握拳，拇指侧顶住剑突与脐间的腹中线部位，快速向内、向上冲击腹部。妊娠末期或过度肥胖者用胸部冲击法。教材P239。

157. [A2型题 | 应用] batch035-M8-A2-004

模块：M8 | 页码：教材P243

男性，25岁，在游泳池溺水被救上岸。查体：意识丧失，无呼吸，无脉搏。现场急救人员首先应采取的复苏措施是

- A. 立即倒水，控出呼吸道内积水
- B. 立即行胸外心脏按压
- C. 即行人工通气后再胸外按压 ☒
- D. 立即实施电除颤
- E. 即建立静脉通道给予肾上腺素

答案：C

解析：淹溺最重要的复苏措施是尽快恢复通气和氧供。人工通气是淹溺复苏最重要的措施，如未发生心脏骤停，迅速人工通气可增加存活机会。大多数淹溺者在溺水过程中只吸入少量水，并不造成气道梗阻，人工呼吸前只需适当清除口中可视异物。检查无意识、无呼吸后，立即胸外心脏按压，按压与通气比30:2。教材P243。

158. [A2型题 | 应用] batch035-M8-A2-005

模块：M8 | 页码：教材P244

女性，30岁，妊娠28周，因突发心脏骤停需行心肺复苏。关于孕妇CPR的特殊注意事项，正确的是

- A. 孕妇应取仰卧位实施胸外按压
- B. 将患者整体向左侧倾斜 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ☒
- C. 胸外按压部位取胸骨下段
- D. 人工通气时无需压迫环状软骨
- E. 导管内径较非孕妇女大0.5~1.0mm

答案：B

解析：妊娠20周后，为减少妊娠子宫对静脉回流和心输出量的影响，应垫高右腹部使孕妇向左侧倾斜 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 后再实施胸外按压。因膈肌抬高，胸外按压可取胸骨中间稍上部位。对无意识孕妇人工通气时应持续压迫环状软骨以防误吸。孕妇可能存在气道水肿，使用气管导管内径要小0.5~1.0mm。教材P244。

159. [A2型题 | 应用] batch035-M8-A2-006

模块：M8 | 页码：教材P246-247

男性，50岁，心脏骤停经CPR后恢复自主循环（ROSC），但意识未恢复。关于脑复苏处理，下列哪项是正确的

- A. 积极降低血压以减轻脑水肿
- B. 过度通气PaCO₂降至25~30mmHg
- C. 舒张压<120mmHg时一般不需要处理 ✓
- D. 常规输注含糖液体补充能量
- E. 体温升高时首选药物降温处理

答案：C

解析：脑复苏需维持足够的脑灌注压。在一定的高血压状态进一步提高CBF可能对脑复苏有利，舒张压<120mmHg时一般不需要处理。过度通气使PaCO₂降低可引起脑血管收缩而减少CBF，维持PaCO₂在35~40mmHg是安全和合适的。除非有低血糖发生，一般应避免输注含糖液体。体温升高应积极处理，可药物或物理降温。教材P246-247。

160. [A3型题 | 应用] batch035-M8-A3-001

模块：M8 | 页码：教材P235

男性，65岁，在家中突然倒地，家属发现其呼之不应，无呼吸，立即拨打急救电话。急救人员到达现场后，确认患者无意识、无呼吸、无脉搏。该患者CPR的复苏顺序应为

- A. ABC(开放气道人工呼吸胸外按压)
- B. CAB(胸外按压开放气道人工呼吸) ✓
- C. BAC(人工呼吸开放气道胸外按压)
- D. ACB(开放气道胸外按压人工呼吸)
- E. CBA(胸外按压人工呼吸开放气道)

答案：B

解析：心脏骤停大多由心脏疾病引起，共识推荐以先进行胸外按压为序，流程为C—A—B。即先进行胸外按压（Circulation），再开放气道（Airway），然后人工呼吸（Breathing）。因为心脏骤停最初数分钟内，血中氧合血红蛋白还保持在一定水平，心、脑的氧供更多地取决于血流量的降低程度。教材P235。[源:考研真题 GS-2019-049]

161. [A3型题 | 应用] batch035-M8-A3-002

男性，65岁，在家中突然倒地，家属发现其呼之不应，无呼吸，立即拨打急救电话。急救人员到达现场后，确认患者无意识、无呼吸、无脉搏。心电监护显示心室颤动。在给予1次电除颤后，下一步应立刻采取的措施是

- A. 立即检查心律和脉搏
- B. 立即再次行电除颤
- C. 行5组CPR约2分钟再查心律脉搏 ✓
- D. 立即静脉注射肾上腺素
- E. 立即行气管插管术

答案：C

解析：当发现心室颤动或无脉性室性心动过速时，急救人员应先电击除颤1次，后立刻进行5组CPR（约2分钟），之后再检查心律和脉搏，必要时再行电除颤。电除颤后心脏常处于无灌注或低灌注状态，电击后立刻胸外按压2分钟有助于心律恢复。教材P237。

162. [A3型题 | 分析] batch035-M8-A3-003

模块：M8 | 页码：教材P241-242

男性，65岁，在家中突然倒地，家属发现其呼之不应，无呼吸，立即拨打急救电话。急救人员到达现场后，确认患者无意识、无呼吸、无脉搏。心电监护显示心室颤动。经1次电除颤和5组CPR后，复查心电监护仍显示心室颤动。此时应给予的药物是

- A. 静注肾上腺素1mg,继续CPR后再除颤 ✓
- B. 静注硫酸镁2g,继续CPR后再次电除颤
- C. 静注利多卡因100mg,继续CPR
- D. 静注碳酸氢钠100ml,继续CPR
- E. 静注胺碘酮300mg,继续CPR后再除颤

答案：A

解析：复苏抢救程序：在1次电击和CPR后，如VF/VT持续存在，推荐给予血管升压药物（肾上腺素1mg），但不能因给药而中断CPR。反复电除颤、CPR和应用血管升压药后，如果VF/VT仍持续存在，可使用抗心律失常药（首选胺碘酮）。本例为电除颤+CPR后VF仍持续，应首先给予血管升压药物。教材P241-242。

163. [B1型题 | 记忆] batch035-M8-B1-001

模块：M8 | 页码：教材P241

心肺复苏过程中，药物经气管内给药时，用量是经静脉给药剂量的多少倍

- A. 1倍剂量
- **B. 2~2.5倍剂量** ✓
- C. 3~4倍剂量
- D. 5倍剂量
- E. 无需调整剂量

答案：B

解析：如果静脉通道不能建立，复苏药物可经由气管内给予，用量是经静脉给药剂量的2~2.5倍。静脉给药是最常用途径，一般药物经由外周静脉到达心脏需要1~2分钟。骨髓途径效果相当于中心静脉通道。教材P241。

164. [B1型题 | 理解] batch035-M8-B1-002

模块：M8 | 页码：教材P241

心肺复苏过程中，无法建立静脉通道时，其效果相当于中心静脉通道的给药途径是

- A. 气管内给药
- **B. 骨髓腔内给药** ✓
- C. 肌肉注射
- D. 皮下注射
- E. 口服给药

答案：B

解析：由于骨髓腔有不会塌陷的血管丛，骨髓途径是可供选择的给药途径，其效果相当于中心静脉通道。如果无法建立静脉通道，可建立经骨髓给药通道。气管内给药用量是经静脉给药剂量的2~2.5倍。教材P241。

165. [X型题 | 记忆] batch035-M8-X-001

模块：M8 | 页码：教材P234

院外心脏骤停（OHCA）或院内心脏骤停（IHCA）的"生存链"包括的环节有

- **A. 识别心脏骤停并启动急救系统** ✓
- **B. 立即行心肺复苏** ✓
- **C. 尽早实施电除颤** ✓
- **D. 进行高级生命支持** ✓

- E. 复苏后监护和幸存者康复 ☒

答案：ABCDE

解析：生存链包括六个环节：①识别心脏骤停和启动急救服务系统；②立即心肺复苏；③尽早电除颤；④进行高级生命支持；⑤复苏后监护；⑥幸存者康复。前三个环节构成基本生命支持（BLS）的主要内容。教材P234。

166. [X型题 | 理解] batch035-M8-X-002

模块：M8 | 页码：教材P231

下列哪些因素可以引起心脏骤停

- A. 冠心病心肌梗死 ☒
- B. 严重低钾血症 ☒
- C. 张力性气胸 ☒
- D. 淹溺（溺水） ☒
- E. 药物中毒 ☒

答案：ABCDE

解析：心脏骤停的原因包括心脏性（冠心病、心肌病、电生理紊乱等）、呼吸性（通气不足、上呼吸道梗阻、呼吸衰竭）、循环性（张力性气胸、心脏压塞、肺栓塞、出血、脓毒症等）、代谢性（低钾血症、高钾血症、低镁血症等）、中毒（药物、毒品、气体中毒）和环境因素（雷击、触电、低/高温、淹溺）等。教材P231。

167. [X型题 | 理解] batch035-M8-X-003

模块：M8 | 页码：教材P237-238

关于小儿心肺复苏的特点，正确的有

- A. 小儿心脏骤停多因呼吸功能障碍所致，成人多因心脏原因所致 ☒
- B. 小儿心脏骤停中约78%为心室静止 ☒
- C. 8岁以下患儿应先求救EMSS、再急救
- D. 婴儿胸外按压可采用双指按压法 ☒
- E. 小儿双人复苏时按压与通气比为15:2 ☒

答案：ABDE

解析：A对：成人心脏骤停多因突发心脏原因，小儿更多因呼吸功能障碍。B对：小儿心脏骤停中约78%是心室静止，其次为心动过缓或无脉性电活动，室性心律发生率<10%。C

错：只有一位急救人员时，对8岁以下患儿应先急救2分钟再求救EMSS，即先急救、再求救。D对：婴儿可采用平卧位双指按压法。E对：小儿双人复苏时按压与通气比为15:2，单人时同成人30:2。教材P237-238。

168. [X型题 | 理解] batch035-M8-X-004

模块：M8 | 页码：教材P243

关于低温致心脏骤停的复苏处理，正确的有

- A. 低温致心脏骤停的救治原则是在积极处理低体温的同时进行CPR ✓
- B. 中心体温 $<30^{\circ}\text{C}$ 时电除颤往往无效 ✓
- C. 重度低体温（ $<30^{\circ}\text{C}$ ）应采用主动体内复温 ✓
- D. 低温时心脏对药物和电除颤的反应性明显下降 ✓
- E. 人工通气时应尽可能给予加温加湿氧气 ✓

答案：ABCDE

解析：A对：低温致心脏骤停的救治原则是在积极处理低体温的同时进行CPR。B对：中心体温 $<30^{\circ}\text{C}$ 时电除颤往往无效，需复温至 30°C 以上再考虑除颤。C对：重度低体温（ $<30^{\circ}\text{C}$ ）和无灌注心律者采用主动体内复温。D对：低温时心脏对药物、起搏刺激及电除颤的反应性明显下降。E对：人工通气时尽可能给予加温（ $32\sim 34^{\circ}\text{C}$ ）加湿氧气面罩通气。教材P243。

M9（24题）

169. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-001

模块：M9 | 页码：教材P249

创伤指数（TI）评分中，属于轻伤的分值范围是

- A. 5~7分 ✓
- B. 8~10分
- C. 8~17分
- D. 10~15分
- E. >17 分

答案：A

解析：TI值包括受伤部位、损伤类型、循环、意识、呼吸五项参数，按异常程度记1、3、5或6分，相加得5~30分。TI值5~7分为轻伤；8~17分为中重度伤； >17 分为极重伤（预计死亡率约50%）。教材P249。

170. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-002

模块：M9 | 页码：教材P249

CRMAS评分法中，总分达到下列哪项可判断为极重度伤

- A. 9~10分
- B. 7~8分
- C. 6分及以下 ☒
- D. 4分及以下
- E. 3分及以下

答案：C

解析：CRMAS评分法以循环（C）、呼吸（R）、胸腹部（A）、运动（M）、语言（S）五项为评判指标，每项0~2分，总分9~10分为轻伤，7~8分为重伤，6分及6分以下为极重度伤。教材P249。

171. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-003

模块：M9 | 页码：教材P250

批量伤员分拣时，红色标签代表的含义是

- A. 轻伤，可稍后处理
- B. 重伤，应尽早抢救
- C. 危重伤，随时有生命危险 ☒
- D. 濒死伤，不作抢救
- E. 已死亡，无需处理

答案：C

解析：红色标签为危重伤，表示伤病情十分严重，随时可致生命危险，为急需抢救者，也称“第一优先”；黄色为重伤（“第二优先”）；绿色为轻伤（“第三优先”）；黑色为濒死伤或死亡。教材P250。

172. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-004

模块：M9 | 页码：教材P251

使用止血带止血时，上臂大出血应扎止血带的部位是

- A. 上臂下1/3处
- B. 上臂中1/3处
- C. 上臂上1/3处 ☒
- D. 上臂中下1/3交界处
- E. 肘关节部位

答案：C

解析：上臂大出血应扎在上臂上1/3处，因为上臂中下1/3处有神经紧贴骨面，不宜扎止血带以免损伤神经。下肢大出血应扎在大腿中上1/3处。教材P251。

173. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-005

模块：M9 | 页码：教材P251

使用止血带时，扎止血带的时间以不超过多久为宜

- A. 1小时 ☒
- B. 2小时
- C. 3小时
- D. 4小时
- E. 30分钟

答案：A

解析：扎止血带时间以<1小时为宜，必须延长时应在1小时左右放松一次（约1~2分钟），但没有绝对安全的止血带使用标准。在预计松开止血带即无法止血、肢体离断伤等危急情况下不应松开止血带。教材P251。

174. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-006

模块：M9 | 页码：教材P252

创伤急救中包扎的目的不包括****

- A. 保护伤口
- B. 减少污染
- C. 固定敷料
- D. 协助止血
- E. 骨折复位 ☒

答案：E

解析：包扎的目的是保护伤口、减少污染、固定敷料和协助止血。骨折复位不属于包扎的目的，而是固定的目的之一。教材P252。

175. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-007

模块：M9 | 页码：教材P253

创伤急救中对骨折部位进行临时固定时，正确的处理原则是

- A. 外露骨折端应立即送回伤口
- B. 畸形伤部应先行复位再固定
- **C. 外露骨折端暂不送回伤口** ✓
- D. 固定松紧要尽量紧以制动
- E. 所有骨折均应先复位后固定

答案：C

解析：固定原则：注意伤员全身情况，外露的骨折端暂不送回伤口，畸形的伤部也不必复位，固定要牢靠，松紧要适度。教材P253。

176. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-008

模块：M9 | 页码：教材P255

多发伤是指人体在单一机械致伤因素作用下，同时或相继累及解剖部位的数目是

- A. 一个或以上
- **B. 两个或两个以上** ✓
- C. 三个或三个以上
- D. 四个或四个以上
- E. 五个或五个以上

答案：B

解析：多发伤是指人体在单一机械致伤因素作用下，同时或相继累及两个或两个以上解剖部位的损伤。常见累及部位包括头颅、颈部、胸部、腹部、泌尿生殖系统、骨折和严重软组织损伤等。教材P255。

177. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-009

模块：M9 | 页码：教材P255

多发伤的第一个死亡高峰出现在伤后

- A. 数分钟内 ☒
- B. 30分钟内
- C. 1小时内
- D. 6~8小时内
- E. 数天或数周后

答案：A

解析：多发伤有三个死亡高峰：第一死亡高峰出现在伤后数分钟内，为即时死亡，死亡原因主要为脑、脑干、高位脊髓的严重创伤或心脏主动脉等大血管撕裂；第二死亡高峰出现在伤后6~8小时内；第三死亡高峰出现在伤后数天或数周。教材P255。

178. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-010

模块：M9 | 页码：教材P256

多发伤检查中，CRASHPLAN记忆顺序中第一个字母C代表的含义是

- A. 颅脑 (cranium)
- B. 心脏 (cardiac) ☒
- C. 胸部 (chest)
- D. 循环 (circulation)
- E. 颈椎 (cervical)

答案：B

解析：CRASHPLAN的含义：C (cardiac, 心脏)，R (respiration, 呼吸)，A (abdomen, 腹部)，S (spine, 脊柱)，H (head, 头部)，P (pelvic, 骨盆)，L (limb, 四肢)，A (arteries, 动脉)，N (nerves, 神经)。但检伤应按照头-颈-胸-腹-肢体-脊柱的顺序进行。教材P256。

179. [A1型题 | 记忆] batch035-M9-A1-011

模块：M9 | 页码：教材P263

挤压综合征典型的临床表现为三联征，其内容包括

- A. 肢体肿胀、低钾血症、急性肾衰竭
- B. 肢体肿胀、高钾血症、急性肾衰竭
- C. 肢体肿胀、肌红蛋白尿、高钾血症 ☒

- D. 肢体肿胀、肌红蛋白尿、低钠血症
- E. 肢体肿胀、高钾血症、肝衰竭

答案：C

解析：挤压综合征是指四肢或躯干肌肉丰富部位被外部重物长时间挤压，解除压迫后出现以肢体肿胀、肌红蛋白尿、高钾血症为特点的急性肾衰竭。多在意外事故、自然灾害及战争时发生。教材P263。

180. [A2型题 | 应用] batch035-M9-A2-001

模块：M9 | 页码：教材P258

男性,45岁。车祸致头部外伤昏迷、腹部闭合性损伤伴腹腔内出血。查体：BP80/50mmHg，P120次/分，左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。颅脑CT示硬膜下血肿、脑挫裂伤。腹部B超示脾破裂、腹腔大量积液。此时最合理的处理顺序是

- A. 先抗休克,待血压稳定后再处理颅脑腹部损伤
- B. 先开颅清除血肿，再剖腹探查止血
- C. 先剖腹探查止血，再开颅清除血肿
- **D. 分组同时行开颅和剖腹手术** ✓
- E. 仅行抗休克治疗，不做手术

答案：D

解析：多发伤有两个以上部位需要手术时，胸腹联合伤可同台分组行开胸及剖腹探查术。颅脑损伤伴有脏器损伤时，根据各脏器损伤轻重程度采取先重后轻的原则；本例颅脑损伤（脑疝征象）与腹部损伤（出血性休克）均危及生命，应分组同时手术。教材P258。

181. [A2型题 | 应用] batch035-M9-A2-002

模块：M9 | 页码：教材P263

男性,30岁。地震中被倒塌的建筑物压埋双下肢8小时，被救出后双下肢肿胀明显，触痛剧烈，有开放性伤口活动性出血。现场急救时，以下处理措施错误的是

- A. 立即解除重物压迫
- **B. 抬高伤肢并按摩促进消肿** ✓
- C. 伤肢制动并暴露于凉爽处
- D. 对开放性出血及时止血
- E. 有骨折者给予临时固定

答案：B

解析：挤压伤现场急救：及时解除重物压迫，伤肢做好制动、尽量减少活动，将伤肢暴露于凉爽处或用凉水降低温度以降低组织代谢和减少毒性物质吸收。注意绝不能抬高伤肢，更不能对伤患处进行按摩、热敷和活动，否则会加快毒性物质吸收并严重损伤肾功能。教材P263。

182. [A2型题 | 应用] batch035-M9-A2-003

模块：M9 | 页码：教材P264

男性,25岁。右小腿被重物挤压后肿胀、疼痛2小时。查体：右小腿中段明显肿胀，皮肤张力高，局部有瘀斑，足背动脉搏动减弱，被动屈趾时疼痛加重，尿肌红蛋白持续阳性。此时最紧急的处理措施是

- A. 抬高患肢并热敷紧急
- B. 使用脱水剂减轻肿胀
- C. 紧急行筋膜隔室切开减压术 ☒
- D. 应用抗生素预防感染
- E. 使用血管扩张药物

答案：C

解析：骨筋膜隔室综合征的筋膜隔室切开术适应证：肢体明显肿胀张力高、尿肌红蛋白持续阳性、筋膜隔室内压力超过40mmHg或高于舒张压-30mmHg。本例符合上述条件，应及时手术切开减压。教材P264。[源:考研真题 GS-2007-162-2]

183. [A2型题 | 应用] batch035-M9-A2-004

模块：M9 | 页码：教材P257

男性,35岁。车祸致胸部外伤，右侧多发肋骨骨折、血气胸。行胸腔闭式引流术后，置管即刻引流出血液1200ml，随后3小时引流速度仍为250ml/h。此时应采取的处理措施是

- A. 继续观察，保守治疗
- B. 增加负压吸引
- C. 开胸探查止血 ☒
- D. 输血补液继续观察
- E. 更换更粗的引流管

答案：C

解析：胸部多发伤合并腹部损伤时，多数情况下可先行胸腔闭式引流术。当置管后一次性引流量 $>1000\sim 1500\text{ml}$ ，或3小时内引流速度仍 $>200\text{ml/h}$ 时，应行开胸探查。本例即刻引流量 1200ml 且后续3小时引流速度 250ml/h ，符合开胸探查指征。教材P257。[源:考研真题GS-2014-084]

184. [A2型题 | 应用] batch035-M9-A2-005

模块：M9 | 页码：教材P261

男性,40岁。锅炉爆炸致全身多处烧伤合并冲击伤，出现胸闷、憋气，心率先缓慢至45次/分，持续约2小时后加快至180次/分。补液后脉搏增至160次/分，伴有心律失常。此时应紧急采取的措施是

- A. 立即停止补液缓慢
- B. 静脉缓慢注射强心药物 ☒
- C. 快速大量补液扩张血容量
- D. 使用镇静药物抑制烦躁
- E. 行气管切开术

答案：B

解析：烧伤合并冲击伤时会出现心肺功能障碍，补液的同时需密切注意呼吸、心率、心律的改变。在补足液体量后，脉搏增至150次/分以上并伴有其他心律失常时，可静脉缓慢注射强心药物。同时应及早给氧，尽量少用镇静、镇痛药物。教材P261。

185. [A3型题 | 应用] batch035-M9-A3-001

模块：M9 | 页码：教材P257

男性,28岁。车祸后30分钟由急救车送入急诊。查体：P120次/分，R28次/分，BP85/55mmHg。神志淡漠，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏。左侧胸壁可见反常呼吸运动，左肺呼吸音减弱。腹部稍膨隆，全腹压痛、反跳痛，移动性浊音阳性。右股骨中段明显肿胀、畸形。该患者应首先进行的评估和处理是

- A. 立即行右股骨骨折固定
- B. 建立静脉通道快速补液抗休克 ☒
- C. 立即行腹部CT检查
- D. 立即行颅脑CT检查
- E. 立即行胸腔穿刺引流

答案：B

解析：多发伤伤员首先进行生命支持，患者BP85/55mmHg，P120次/分，存在休克表现，应迅速建立两条以上静脉通道，立即用乳酸林格液或5%葡萄糖生理盐水1000~2000ml在15~20分钟内输入，抗休克治疗。同时按照CRASHPLAN顺序快速评估，不可等待诊断结束后才开始治疗。教材P257。

186. [A3型题 | 分析] batch035-M9-A3-002

模块：M9 | 页码：教材P259

男性,28岁。车祸后30分钟入院。查体：P120次/分，BP85/55mmHg，神志淡漠。左侧胸壁反常呼吸，左肺呼吸音减弱。腹部膨隆、全腹压痛、移动性浊音阳性。右股骨中段畸形。经快速补液抗休克后，血压仍不稳定。拟行急诊剖腹探查，术中见脾破裂及肝破裂，腹腔大量积血。此时应采取的手术策略是

- A. 彻底切除脾脏和肝脏部分切除
- **B. 仅行纱布填塞止血，快速关腹** ✓
- C. 全面探查后行确定性修复手术
- D. 先关腹待二期再行手术快速
- E. 仅行脾切除，肝损伤保守治疗

答案：B

解析：损伤控制外科（DCS）是针对严重创伤者进行阶段性修复的外科策略，旨在避免“死亡三联征”（低体温、代谢性酸中毒、凝血功能紊乱）。救命手术阶段：控制出血可采用填塞、结扎等简单有效的方法；控制污染采用快速修补、残端封闭等方法；快速关腹。随后进入ICU复苏阶段，待生理紊乱纠正后再行确定性手术。教材P259。

187. [A3型题 | 应用] batch035-M9-A3-003

模块：M9 | 页码：教材P265

男性,32岁。经历严重交通事故后1个月，反复出现车祸场景的噩梦和闪回，不敢乘坐汽车，回避与车祸有关的话题，情绪麻木，易受惊吓，失眠，注意力不集中。PTSD症状核查量表评分为35分。该患者最可能的诊断是

- A. 急性应激障碍
- **B. 创伤应激障碍** ✓
- C. 广泛性焦虑障碍
- D. 抑郁障碍
- E. 适应障碍

答案：B

解析：PTSD诊断要点：遭遇灾难性创伤应激事件、持续重新体验症状（闪回、噩梦）、持续回避创伤相关线索、认知情绪和心境消极改变、警觉性增高、症状持续至少1个月、有明显痛苦或社会功能障碍。PTSD症状核查量表评分>31分即可诊断。本例符合上述所有要点。教材P265。

188. [B1型题 | 理解] batch035-M9-B1-001

模块：M9 | 页码：教材P251

适用于头部和四肢动脉出血的短暂应急止血措施是

- A. 指压止血法 ☒
- B. 加压包扎止血法
- C. 填塞止血法
- D. 止血带止血法
- E. 钳夹止血法

答案：A

解析：指压止血法为短暂应急止血措施，适用于头部和四肢的动脉出血，用手指压在出血近心端的动脉处，将动脉压迫闭合在骨面上阻断血流，达到迅速和临时止血的目的。教材P251。

189. [B1型题 | 理解] batch035-M9-B1-002

模块：M9 | 页码：教材P251

适用于颈部、臀部或其他部位较大而深的伤口难以加压包扎时的止血方法是

- A. 指压止血法
- B. 加压包扎止血法
- C. 填塞止血法 ☒
- D. 止血带止血法
- E. 钳夹止血法

答案：C

解析：填塞止血法适用于颈部、臀部或其他部位较大而深的伤口难以加压包扎时。先将无菌纱布塞入伤口内，如有出血可添加纱布，再用绷带包扎固定。加压包扎止血法适用于四肢、头颈、躯干等体表血管损伤的出血处理。教材P251。

190. [X型题 | 理解] batch035-M9-X-001

模块：M9 | 页码：教材P255

关于多发伤死亡高峰的描述，正确的有

- A. 第一死亡高峰出现在伤后数分钟内 ✓
- B. 第一死亡高峰主要死因为脑、脑干严重创伤或大血管撕裂 ✓
- C. 第二死亡高峰出现在伤后6~8小时 ✓
- D. 第二死亡高峰是抢救的“黄金时间” ✓
- E. 第三死亡高峰出现在伤后1~2天

答案：ABCD

解析：A对：第一死亡高峰出现在伤后数分钟内，为即时死亡。B对：死亡原因主要为脑、脑干、高位脊髓的严重创伤或心脏主动脉等大血管撕裂。C对：第二死亡高峰出现在伤后6~8小时内。D对：这一时间称为黄金时间，死亡原因主要为颅内血肿、血气胸、肝脾破裂等，如抢救及时大部分可免于死亡。E错：第三死亡高峰出现在伤后数天或数周，死亡原因为严重感染或器官功能衰竭。教材P255。

191. [X型题 | 记忆] batch035-M9-X-002

模块：M9 | 页码：教材P250

基本创伤生命支持（BTLS）主要包括的技术有

- A. 心肺复苏 ✓
- B. 止血技术 ✓
- C. 包扎技术 ✓
- D. 固定技术 ✓
- E. 搬运技术 ✓

答案：ABCDE

解析：基本创伤生命支持（BTLS）主要包括现场心肺复苏、止血、包扎、固定和搬运五大技术。这些是院前急救中最基本也是最重要的创伤急救技术，对挽救伤员生命、降低伤残率具有重要意义。教材P250。

192. [X型题 | 理解] batch035-M9-X-003

模块：M9 | 页码：教材P264

关于挤压综合症的全身治疗，正确的有

- A. 挤压伤阶段应大量补液早期成人可达6L/d ✓
- B. 碱化尿液可预防肌红蛋白在肾小管沉积 ✓
- C. 已出现急性肾衰竭时应严格控制液体摄入量 ✓
- D. 急性肾衰竭时应限制使用血液净化措施
- E. 利尿脱水有助于增加肾血流量和防止肾衰竭 ✓

答案：ABCE

解析：A对：挤压伤阶段在监护下给予充分容量复苏，早期成人输液量可达6L/d。B对：给予碳酸氢钠静脉滴注碱化尿液，使尿中酸性正铁血红素溶解度增加，预防肌红蛋白在肾小管沉积。C对：挤压综合征阶段若已出现急性肾衰竭，应严格控制液体摄入量。D错：血液净化措施包括血液透析和持续性血液滤过治疗，是急性肾衰竭的重要治疗手段。E对：在充分容量复苏基础上，利尿脱水有助于增加肾血流量，防止肾衰竭。教材P264。

M10（14题）

193. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-001

模块：M10 | 页码：教材P268

世界卫生组织（WHO）对灾难的定义中，核心要素包括

- A. 仅指自然灾害，非人为
- B. 超出地区承受能力需外部援助 ✓
- C. 仅指人为事故及骚乱
- D. 仅指传染病暴发流行
- E. 仅指战争及武装冲突

答案：B

解析：WHO将灾难定义为任何引起设施破坏、经济严重损失、人员伤亡、人的健康状况及社会卫生服务条件恶化的事件，当其规模超过事发地区所能承受的限度，不得不向事发区以外的地区寻求援助时，称之为灾难。教材P268。

194. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-002

模块：M10 | 页码：教材P268

灾难医学的理念概括为

- A. 始于灾中、重于灾后、延于重建
- B. 始于灾前、重于灾中、延于灾后 ✓

- C. 始于灾前、重于灾后、延于重建
- D. 始于灾前、重于预防、延于治疗
- E. 始于灾中、重于管理、延于恢复

答案：B

解析：灾难医学的理念为始于灾前、重于灾中、延于灾后。灾难医学在快速发展的过程中，逐渐形成自己的学科特点：历史短暂，理论体系尚待成熟；呈现学科交叉性、社会协作性和国际合作性；重视群体效应，以群体利益最大化为目标。教材P268。

195. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-003

模块：M10 | 页码：教材P268

灾难救援分期中，紧急救援期一般指灾后多长时间

- A. 1周内 ☒
- B. 1个月内
- C. 2周内
- D. 24小时内
- E. 72小时内

答案：A

解析：灾难救援分为3期：紧急救援期一般指灾后1周，尤其要重视“黄金72小时”，针对创伤为主；持续救援期为灾后1周至1个月，针对高发疾病，尽量降低致残率及减少人员伤亡；恢复重建期为减灾1个月以后，针对常见病及传染病的防治。教材P268。

196. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-004

模块：M10 | 页码：教材P268

王一镗教授提出的现代灾难医学救援三七分理念中，包括的内容是

- A. 三分救援，七分自救 ☒
- B. 三分自救，七分救援
- C. 三分管理，七分业务
- D. 三分平时，七分战时
- E. 三分教育，七分研究

答案：A

解析：王一镗教授提出的三七分理念包括：三分救援，七分自救；三分急救，七分预防；三分业务，七分管理；三分战时，七分平时；三分提高，七分普及；三分研究，七分教育。这是处理灾难救援及发展灾难医学必须遵循的基本理念。教材P268。

197. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-005

模块：M10 | 页码：教材P275

根据突发公共卫生事件的性质、危害程度和涉及范围，特别重大突发公共卫生事件的分级为

- A. I级 ☒
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. V级

答案：A

解析：突发公共卫生事件划分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）和一般（IV级）四级。特别重大事件包括肺鼠疫/肺炭疽在大中城市发生并有扩散趋势、SARS/人感染高致病性禽流感病例并有扩散趋势、涉及多个省份的群体性不明原因疾病等。教材P275。

198. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-006

模块：M10 | 页码：教材P273

灾难伦理学遵循的生命伦理学基本原则不包括****

- A. 尊重原则
- B. 自主性原则
- C. 不伤害原则
- D. 公正原则
- E. 效益最大化原则 ☒

答案：E

解析：灾难伦理学遵循生命伦理学基本原则，主要包括：尊重原则、自主性原则、不伤害原则和公正原则。此外，由于资源匮乏及时间紧迫，还面临3R伦理问题，包括责任（responsibility）、限制（restriction）和资源（resource）。效益最大化原则不属于生命伦理学的基本原则。教材P273。

199. [A1型题 | 记忆] batch035-M10-A1-007

模块：M10 | 页码：教材P268

灾难救援的基本原则不包括****

- A. 人道救援原则
- B. 快速反应原则
- **C. 经济利益优先原则** ✓
- D. 科学及专业救援原则
- E. 检伤分类及分级救援原则

答案：C

解析：灾难救援的基本原则包括：人道救援原则、快速反应原则、安全救援及自救互救原则、科学及专业救援原则、区域救援原则、检伤分类及分级救援原则、备灾原则。经济利益优先原则不属于灾难救援的基本原则。教材P268。

200. [A2型题 | 应用] batch035-M10-A2-001

模块：M10 | 页码：教材P250

某地发生强烈地震，现场有大量伤员。急救人员对伤员进行分拣：伤员甲，呼吸心脏骤停，现场无复苏条件；伤员乙，左大腿开放性骨折，活动性出血，神志清楚；伤员丙，多处软组织擦伤，能自行行走；伤员丁，连枷胸伴呼吸困难，口唇发绀。按照我国统一分拣标签，应佩戴红色标签的伤员是

- A. 伤员甲和乙
- **B. 伤员乙和丁** ✓
- C. 伤员丙和丁
- D. 仅伤员丁伤员乙
- E. 仅伤员甲

答案：B

解析：红色标签（危重伤/第一优先）：呼吸心脏骤停、气道阻塞、活动性外出血、严重多发伤、大面积烧烫伤、重度休克等。伤员甲呼吸心脏骤停但现场无复苏条件应佩戴黑色标签（濒死伤/死亡），伤员乙活动性出血属红色，伤员丙为绿色（轻伤），伤员丁连枷胸伴呼吸困难属红色（危重伤）。教材P250。

201. [A2型题 | 应用] batch035-M10-A2-002

某地区发生严重洪涝灾害，大量灾民集中安置在临时避难所。灾后第3天，安置点出现多例腹泻病人，水样便，无脓血。下列预防措施中，应优先采取的是

- A. 立即对全部腹泻病人隔离治疗
- **B. 恢复和保障安全饮用水供应** ✓
- C. 对全体灾民进行抗生素预防性用药
- D. 开展大规模疫苗接种
- E. 对安置点进行终末消毒

答案：B

解析：灾难后饮用水供应系统的破坏常在灾后早期引起肠道传染病的大规模暴发和流行。由于饮水系统的破坏对人群构成的威胁最为严重，应采取一切可能的措施，首先恢复并保障安全的饮用水供应。煮沸消毒和含氯消毒剂消毒是饮水消毒的主要方法。教材P277、P279。

202. [A2型题 | 应用] batch035-M10-A2-003

某地发生化工厂爆炸事故，现场有大量伤员。一名救援队员发现伤员意识模糊，呼吸急促（频率35次/分），脉搏细速（120次/分），右前臂开放性骨折伴活动性出血，躯干有大面积烧伤。按照批量伤员分拣原则，该伤员应佩戴的标签和优先顺序是

- A. 绿色标签，第三优先
- B. 黄色标签，第二优先
- **C. 红色标签，第一优先** ✓
- D. 黑色标签，不抢救
- E. 蓝色标签，第四优先

答案：C

解析：红色标签（危重伤/第一优先）指伤病情十分严重，随时可致生命危险者，需优先抢救。该伤员意识模糊、呼吸急促、脉搏细速、有活动性出血和大面积烧伤，符合危重伤标准，应佩戴红色标签，作为第一优先进行抢救和转运。黄色标签为重伤（第二优先），绿色为轻伤（第三优先），黑色为濒死伤或死亡。教材P250。

203. [B1型题 | 理解] batch035-M10-B1-001

灾难发生后第5天，救援工作重点主要针对创伤伤员进行救治。此期属于灾难救援的

- A. 紧急救援期 ☒
- B. 持续救援期
- C. 恢复重建期
- D. 备灾期急救
- E. 后效应期

答案：A

解析：灾难救援分为3期：紧急救援期一般指灾后1周，尤其要重视黄金72小时，针对创伤为主；持续救援期为灾后1周至1个月，针对高发疾病；恢复重建期为减灾1个月以后。第5天仍在紧急救援期内。教材P268。

204. [X型题 | 理解] batch035-M10-X-001

模块：M10 | 页码：教材P277

灾难造成传染病流行的机制包括

- A. 饮用水供应系统破坏 ☒
- B. 食物短缺和燃料短缺 ☒
- C. 水源污染与破坏 ☒
- D. 居住环境破坏人口迁徙 ☒
- E. 对媒介生物生态平衡影响 ☒

答案：ABCDE

解析：灾难造成传染病流行的机制包括：饮用水供应系统破坏（常引起肠道传染病大规模暴发）、食物短缺（造成食品霉变和腐败导致食物中毒）、燃料短缺（迫使食用生水、进食生冷食物）、水源污染（引起水源性疾病暴发流行）、居住环境破坏（虫媒传染病和呼吸道传染病发病率增加）、人口迁徙（引起地方性疾病传播及计划免疫空白人群暴露）、对媒介的影响（蝇类等媒介生物滋生）。教材P277-278。

205. [X型题 | 理解] batch035-M10-X-002

模块：M10 | 页码：教材P278

关于灾后防疫分期的描述，正确的有

- A. 灾后防疫分为应急响应、现场救援和持续发展三个阶段 ☒
- B. 前两个阶段主要由外援防疫力量完成 ☒

- C. 应急响应阶段需对废墟、尸体、临时安置点进行全面消毒杀菌 ✓
- D. 现场救援阶段应培训和教育当地居民防疫知识 ✓
- E. 持续发展阶段由灾区当地防疫力量承担工作 ✓

答案：ABCDE

解析：灾后防疫分为三个阶段：应急响应阶段（灾难发生初期，对废墟、尸体、临时安置点进行全面消毒杀菌，及时发现疫情）、现场救援阶段（培训和教育当地居民，构建当地防疫力量，进行防疫知识和技能专项培训）、持续发展阶段（对防疫现状进行分析，科学评估疫情风险，调查与传染病相关因素，改进和调整防疫方案）。前两个阶段主要由外援防疫力量完成，最后一个阶段主要由灾区当地防疫力量承担。教材P278。

206. [X型题 | 理解] batch035-M10-X-003

模块：M10 | 页码：教材P274

关于突发公共卫生事件的特点，正确的有

- A. 突发性，通常没有预兆，不易预测 ✓
- B. 严重危害性病人数量多,病情严重或死亡率高 ✓
- C. 传播速度快，对社会正常生活构成威胁 ✓
- D. 仅影响个别群体，不影响全体公民
- E. 突发公共卫生事件应急工作应遵循预防为主方针 ✓

答案：ABCE

解析：A对：这类事件通常突发，紧急且无预兆，不易预测，难以完全避免。B对：病人数量多，病情严重或死亡率高。C对：疾病直接影响到相当人数的群体，传播速度快，给社会造成严重危害。D错：事件影响全体公民，对整个社会的正常生活构成威胁。E对：突发公共卫生事件应急工作，应遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。教材P274-275。

M11（14题）

207. [A1型题 | 记忆] batch035-M11-A1-001

模块：M11 | 页码：教材P281

关于灾难现场医学救援的特点，下列描述错误的是

- A. 现场救援包括伤员搜救检伤分类现场急救转运
- B. 救援任务紧迫组织结构松散,需高度统一指挥

- C. 现场救援人员易致心理创伤,需早期干预
- D. 为防止灾后暴发疫情,需进行现场卫生防疫
- E. 现场救援优先保障伤员,救援人员安全其次 

答案: E

解析: 灾难现场医学救援的前提是确保救援人员、被救人员和旁观者安全, 保证救援人员自身安全是实施救援的基础, 并非次要地位。教材P281。

208. [A1型题 | 记忆] batch035-M11-A1-002

模块: M11 | 页码: 教材P286

灾难现场检伤分类中, 采用4色标签标识伤员救治优先顺序, 其中黑色标签的含义是

- A. 存活可能性极小, 无法救治 
- B. 伤势轻, 可等待处理
- C. 伤势较重, 暂无生命危险
- D. 伤势严重, 需紧急救治
- E. 需进一步观察后再分类

答案: A

解析: 黑色标签为期待救治, 用于标示存活可能性极小的无法救治者; 红色为优先救治 (伤势严重需紧急救治), 黄色为延迟救治 (暂无生命危险), 绿色为等待救治 (轻伤可走动者)。教材P286。

209. [A1型题 | 记忆] batch035-M11-A1-003

模块: M11 | 页码: 教材P286

灾难现场采用START (simple triage and rapid treatment) 原则快速分拣时, "30-2-可以做"方法中"30"代表

- A. 收缩压30mmHg
- B. 呼吸频率30次/分 
- C. 毛细血管再充盈时间30秒
- D. 脉搏30次/分
- E. GCS评分30分

答案: B

解析：START方法中"30"指呼吸频率30次/分；"2"指毛细血管再充盈时间2秒；"可以-做"指遵从指挥的能力。只要呼吸频率<30次/分、毛细血管再充盈时间<2秒、能遵从指挥行走，则为轻伤。教材P286。

210. [A1型题 | 理解] batch035-M11-A1-004

模块：M11 | 页码：教材P282

关于灾难现场止血带使用的描述，正确的是

- A. 止血带可用电线、铁丝代替
- B. 止血带应直接缠绕在皮肤上以增强止血效果
- C. 止血带绑扎松紧度以刚好停止出血即可
- **D. 止血带最长使用时间不宜超过4小时** ✓
- E. 止血带应放置在出血伤口下方5cm处

答案：D

解析：止血带使用要点：严禁用电线、铁丝、绳索代替；不能直接缠在皮肤上，须用垫子垫上；松紧度以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度；最长不宜超过4小时；应放在出血伤口上方5cm，尽量靠近伤口。教材P282。

211. [A1型题 | 理解] batch035-M11-A1-005

模块：M11 | 页码：教材P284

怀疑脊柱骨折的伤员在搬运时，下列做法正确的是

- A. 脊柱骨折伤员应采用侧卧位搬运
- B. 搬运时允许脊柱有弯曲以方便通过
- **C. 搬运时应保持躯体呈一直线** ✓
- D. 颈椎骨折搬运时无须专人固定头部
- E. 采用一人抬胸一人抬腿的拉车式搬运法

答案：C

解析：脊柱骨折搬运时必须托住伤员的头、肩、臀和下肢，保持躯体呈一直线，严禁用拉车式搬运；怀疑颈椎骨折须有专人牵引固定头部，用颈托或沙袋固定，防止头部旋转。教材P284。

212. [A2型题 | 应用] batch035-M11-A2-001

某地震现场，一男性伤员被救出后检查：呼吸26次/分，毛细血管再充盈时间1.5秒，能遵从指令行走。根据START分拣原则，该伤员应归为

- A. 红色（立即救治）
- B. 黄色（延迟救治）
- C. 绿色（轻伤，等待救治） ☒
- D. 黑色（期待救治）
- E. 需立即转运至后方医院

答案：C

解析：START原则：呼吸频率<30次/分、毛细血管再充盈时间<2秒、能遵从指挥行走，则为轻伤（绿色标签）。该伤员三项条件均满足（呼吸26次/分、毛细血管再充盈1.5秒、能行走），应归为轻伤。教材P286。

213. [A2型题 | 应用] batch035-M11-A2-002

地震现场一伤员被重物砸伤右大腿，伤口可见活动性喷射状出血，远端肢体苍白、动脉搏动消失。现场急救时应首先采取的措施是

- A. 立即行骨折夹板固定
- B. 搬运至安全区域再处理
- C. 清创缝合伤口出血
- D. 使用止血带控制出血 ☒
- E. 静脉输液抗休克治疗

答案：D

解析：存在致命性外出血时，应在出血控制后才能进行其他步骤。该伤员累及大血管的严重四肢创伤，喷射状出血提示动脉损伤，应首先使用止血带控制出血，再行骨折固定等后续处理，遵循C-A-B顺序。教材P299-300。

214. [A3型题 | 应用] batch035-M11-A3-001

某地震发生后，现场医疗救援队短时间内接收大量伤员。伤员甲：呼吸28次/分，毛细血管再充盈时间1秒，能行走，意识清楚。根据START分拣原则，该伤员应分拣为

- A. 红色（立即救治）
- B. 黄色（延迟救治）
- C. 绿色（轻伤，等待救治） ☒
- D. 黑色（期待救治）
- E. 需进一步观察后再分类

答案：C

解析：START原则：呼吸频率<30次/分、毛细血管再充盈时间<2秒、能遵从指挥行走，则为轻伤（绿色标签）。伤员甲三项指标均符合轻伤标准。教材P286。

215. [A3型题 | 应用] batch035-M11-A3-002

模块：M11 | 页码：教材P286

某地震发生后，现场医疗救援队短时间内接收大量伤员。伤员乙：呼吸32次/分，毛细血管再充盈时间4秒，无意识，桡动脉脉搏触不清。根据START分拣原则，该伤员应分拣为

- A. 红色（立即救治） ☒
- B. 黄色（延迟救治）
- C. 绿色（轻伤，等待救治）
- D. 黑色（期待救治）
- E. 需进一步观察后再分类

答案：A

解析：START原则：存在无意识、呼吸急促（>30次/分）、毛细血管再充盈延迟（>2秒）、桡动脉脉搏缺失中任何一项，即归为立即救治（红色标签）。伤员乙具备多项指标，应分拣为红色。教材P286。

216. [A3型题 | 分析] batch035-M11-A3-003

模块：M11 | 页码：教材P286

某地震发生后，现场医疗救援队短时间内接收大量伤员。伤员丙：呼吸24次/分，毛细血管再充盈时间1.5秒，神志尚清但不能行走，能遵从指令。根据START分拣原则，该伤员应分拣为

- A. 红色（立即救治）
- B. 黄色（延迟救治） ☒
- C. 绿色（轻伤，等待救治）
- D. 黑色（期待救治）
- E. 需进一步观察后再分类

答案：B

解析：START原则：呼吸频率<30次/分、毛细血管再充盈时间<2秒（满足"30-2"条件），但无法行走，则归为"延迟救治"（黄色标签）。该伤员符合"30-2"条件但不能行走，故分拣为黄色。此处需注意区分"30-2"条件满足但无法行走的黄色判定与存在意识障碍、呼吸急促等红色判定标准。教材P286。

217. [B1型题 | 理解] batch035-M11-B1-001

模块：M11 | 页码：教材P311

在化学灾难现场，非挥发性固态或液态物质，毒性或传染性低，此时救援人员应选用的个体防护级别是

- A. A级个体防护
- B. B级个体防护
- C. C级个体防护
- D. 无需特殊防护
- E. D级个体防护 ☒

答案：E

解析：D级个体防护适用于非挥发性固态或液态物质，毒性或传染性低的情况；A级适用于接触高压蒸气、可经皮肤吸收气体、高毒性化学物、未知化学物等；B级适用于气态有毒化学物质（不经皮肤吸收）、威胁生命浓度；C级适用于非皮肤吸收气态有毒物、浓度已知、非威胁生命浓度。教材P311。

218. [X型题 | 记忆] batch035-M11-X-001

模块：M11 | 页码：教材P282

灾难现场常用的止血方法包括

- A. 指压止血法 ☒
- B. 加压包扎止血法 ☒
- C. 填塞止血法 ☒
- D. 止血带止血法 ☒
- E. 电凝止血法

答案：ABCD

解析：现场常用4种止血方法：指压止血法（适用于肢体及头面部外出血）、加压包扎止血法（适用于大多数活动性出血伤口）、填塞止血法（适用于较大而深的伤口）、止血带止血

法（适用于累及大血管的严重四肢创伤）。电凝止血法为手术室内的止血方法，不适用于灾难现场。教材P282。

219. [X型题 | 理解] batch035-M11-X-002

模块：M11 | 页码：教材P307

关于灾难现场伤员转运的原则，正确的有

- A. 危及生命的严重创伤者应优先转运 ✓
- B. 转运应遵循NEWS原则进行安全评估 ✓
- C. 转运前应向伤员家属交代病情并取得知情同意 ✓
- D. 院前转运应最大限度地缩短运送时间 ✓
- E. 转运途中无须与接收医院保持联系

答案：ABCD

解析：A对：危及生命需立即治疗的严重创伤者优先转运；B对：转运应遵循NEWS原则（Necessary、Enough、Working、Secure）；C对：如伤情相对稳定适合转运，向伤员及家属交代病情并取得同意后实施；D对：院前转运旨在最大限度地缩短运送时间；E错：转运途中应与接收医院保持联系，提前告知伤情和到达时间。教材P307-308。

220. [X型题 | 理解] batch035-M11-X-003

模块：M11 | 页码：教材P287

灾难伤员分级救治的原则包括

- A. 及时合理 ✓
- B. 连续继承 ✓
- C. 治送结合 ✓
- D. 就地治疗
- E. 分类转运

答案：ABC

解析：分级救治原则：①及时合理——做好现场抢救工作，积极后送，勿使伤员在现场过多过久滞留；②连续继承——各级救治应连续不中断，前后紧密衔接，逐步完善；③治送结合——救治与后送相辅相成，缺一不可。D错：灾难现场应遵循分级救治原则，而非单纯就地治疗；E错：分类转运是转运分拣的内容，不属于分级救治三大原则。教材P287。